倪醫師病案紀錄　　初診日期：

姓名

BB

來診原因：

雙牙關痛，張合即痛。 (TMJ) 一週了。

左手臂外側開始麻，時好時麻。

問診：

1、睡眠：好

2、大便：每日行

3、口渴： 尚好

4、手足溫度：雙足溫 ，更年期身熱。

脈診：脈穩定

診斷：

TMJ→足陽明經實症

左手臂麻→手三陽經虛症

針灸處方： 雙 (內庭，合谷，下關，梁丘)

右 (曲池，中渚，後谿)

中藥處方： HT-64　　早晚飯前各服 30粒

解說：

1. TMJ 僅一週 →實症→ 內庭(代厲兌為子穴) ,合谷(止面部疼痛) ,下關(天應) ,梁丘(郄穴)。

2.手臂時好時麻 →虛症→手三陽經母穴

3. HT-64 →(溫經湯加減) 治療更年期身熱

4.脈穩定→身體還好

備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/15

姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
BB	F	目視約四十歲 胖	2008/08/15

來診原因：

1 今年三月感冒後，一直很久沒好，鼻子跟喉嚨一直沒好，喉中一直很乾。

2 之後，六週前摔倒，左足掌內側足脾經會痛，右膝也同時受傷。

3 五週後要唱歌。

4 想減肥。

問診： １睡好 ２大便每日行 ３胃口好 ４口渴有，冷飲 ５雙足溫 ６睡時身熱 ７小便中黃，深黃 ８月經來算正常 ９有排氣，吃藥才有每天大便→小承氣湯
脈診：緩有力→脈不浮故知已無表證
望診： 1、舌診：舌淡黃濕 2、眼診：
診斷： 白虎湯證，小承氣湯
針灸處方： １雙列缺　雙照海　天突→治喉乾 ２右太白　右公孫　右魚際→治左足掌脾經痛，採對稱治療。 ３雙迎香→治鼻病。 ４右膝五針→治膝蓋扭傷。
中藥處方： 石膏五兩　知母五錢　甘草三錢　麥冬三錢　黃芩三錢　天花三錢　夏枯草五錢　辛夷三錢　菖蒲三錢　蒼朮三錢　葛根六錢　厚朴二錢　枳實二錢　大黃四錢 拾付　九碗煮三碗水　早晚飯前
解說： １喉乾，口渴，身熱為白虎湯證。 ２葛根生津液，治喉乾可用之。 ３大黃配上厚朴枳實則攻下不會肚子痛。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
BE	F	87歲　瘦小	2008/08/25 Fax
來診原因：乳癌復發。 體溫：手足，前額皆溫，其他生命跡象正常！ 仍有過敏：咳嗽，打噴嚏，流鼻水，流眼淚。			
問診：			
脈診：			

望診： 1、舌診： 2、眼診：
特殊診斷：
耳診：
診斷：
針灸處方：
中藥處方： 同8/8前方　加蒼朮四錢 拾付　九碗煮三碗水　早晚飯前
解說：辛夷菖蒲開竅治鼻病之外，需要蒼朮收濕才能盡全功。
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/19			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
BM	女	62歲，中等身材，略胖	2008/08/19
來診原因：二個月前因說話不清、身腫、四肢無力，被西醫診斷為ALS (amyotrophic lateral sclerosis；俗稱漸凍人)，故來師處就診。此女自1988年迄今長期服用降血壓藥Diovan，不服藥時血壓140/92mmHg，服藥時120/80mmHg。			
問診： 睡眠：因頻尿無法睡通宵。 胃口：過好 便秘：一星期一次。 小便：淡黃 便秘時腹痛：無。 口渴：無，但理智上會提醒自己喝水。 寒熱：睡時無寒熱，手足溫額涼。 其他：時身瞤動(肌肉跳動)。			
脈診：脈緩有力			
眼診：肝區黃點、心包區有黃塊、腎區反應不好。 舌診：淡白紅。			
診斷：下焦寒實。上焦假熱。			

中藥處方：
炮附子四錢、細辛二錢、大黃四錢、烏藥四錢
澤瀉五錢、茯苓五錢、熟地三錢、補骨脂三錢
川芎三錢、丹皮三錢、白术三錢、豬苓三錢、桂枝五錢
柴胡三錢、鬱金五錢、黃芩三錢、龍膽草三錢
十付，每付九碗水煮成三碗，早晚餐前各一碗。

解說：
1便秘不覺腹痛，屬下焦寒實，用大黃附子細辛湯。
2不吃降血壓藥時140/92，師曰可停藥。且吃降壓藥控制也不能保證不中風。
3此高血壓成因是腎陽不足，因下焦寒，血管收縮，無法有效率排出身體多餘的水份，對管壁的壓力回逆，故高血壓。
4腎陽不足用補骨脂、熟地、澤瀉補腎，炮附子亦補腎。
5雖然此女不口渴，但脈仍有力，手足不寒，仍不到用生附的條件。
6肌肉瞤動是皮下有多餘的水，用五苓散利水。
7眼中肝區有黃點表肝中有毒素，用柴胡、鬱金、黃芩、龍膽草清肝。
8川芎、丹皮可活血化瘀，促進血管彈性。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：

姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**
BM	女	47歲，中等	2008/08/26

來診原因：右側卵巢又痛(以前有癌)，心一直很好，二週前去看牙醫(做Deep clean)後，心悸又來。

問診：
睡眠：在AM1:00～2:00醒
大便正常
小便中黃
口渴尚好
胃口平平
雙足一點冷了
月經準時來，前二天量很多
右下腹痛，在經前經後都會痛

脈診：脈緩有力

望診：
1、**舌診：**淡黃(鮮黃)紅
2、**眼診**：

特殊診斷：

耳診：

診斷： 裡寒濕，右卵巢瘤
中藥處方： 1HT-8(b)桂枝茯苓丸加味　6兩　30x2 午餐前及睡前服 2桂枝四錢 炙甘草四錢 茯苓五錢 柴胡三錢 玉金五錢 黃芩三錢 龍膽草三錢 茜草五錢 白芍八錢 丹皮三錢 川芎三錢 當歸二錢 生附子二錢(另包) 乾薑二錢　十付　九碗水煮成三碗，每天早晚飯前各一碗
解說： 1.師云患者再8天MC來，故趁機攻之。 2.患者在凌晨一兩點鐘會醒，要清一下肝。 3.月經腹痛可用茜草，丹皮、白芍、川芎等入肝經的活血藥治之。
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**
BM	男	約六十歲	2008/08/01
來診原因：			
問診：睡好。小便清,不頻尿。雙足溫。口渴有時，喜溫飲。胃口好,大便每日行。平素抽菸重。體力好。背後生一疣，建議先切片看是否是meloma再說。手溫額涼。			
脈診：脈洪有力			
望診： 1、**舌診：**黃濕厚 2、**眼診** :瞳孔收縮反應好 心區好 肝區有黃點，紋路好 眼白區(心包區)痰多 眼周圍有點青黃色,可能原因有二：一是喝酒；二是肝膽濕熱			
耳診：			
診斷： 肺中濕熱，腸胃溼熱			
針灸處方：			
中藥處方： 皂莢3　大棗2　黃芩 3　黃柏 3　黃連 2　知母3 400 caps　8x3 before meals			
解說：1.抽菸欲戒菸→皂莢加大棗 2.知母去其濕			
備註：			

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
BR	女	45 中等	2008/08/11

來診原因：病人為心瓣膜閉鎖不全之人，因下周要登20000尺之高山，擔心無法呼吸。因掃地在右腎俞處背痛約一周。自述服前方後左側已好許多。

問診：

胃中有嘔心感。
略有心悸。
壓力大，服前方後好許多
睡好
大便時每日一次，時隔日
胃口還好
口渴喜溫水
雙足冷
晚上睡時，時冷時熱，更年期身熱。
手涼額溫

脈診：脈弦(師曰:有水)

望診：
1、舌診：淡黃濕
2、眼診 ：

耳診：

診斷：

針灸處方： 中脘，足三里，左臨泣，束骨，後溪

中藥處方: 半夏三錢，生薑兩片，茯苓四錢，桂枝五錢，炙甘草五錢，大棗十枚，瓜蔞實三錢，枳實三錢，薤白三錢，遠志三錢，補骨脂三錢，澤瀉三錢，柴胡三錢，玉金五錢，龍膽草三錢，黃芩三錢

解說：

小半夏湯去水，桂枝甘草湯去心悸，枳實薤白瓜蔞實治心臟瓣膜閉鎖不全(心氣問題)。柴胡，玉金，龍膽草，黃芩疏肝，木生火，強心。

中脘穴引水往下，足三里去胃中之冷水，足臨泣去帶脈上之痛，束骨瀉膀胱經之實症，後溪治督脈上之痛。

備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2000/01/14			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
BR	F	59歲 很胖	2008/08/13

來診原因：左脅下方痛，半年來區塊持續擴大中，痛是持續的痛。甲狀腺問題，

落髮，臉頰紅如蝴蝶。
問診： １胃口好 ２大便又秘，近六個月不規則，色黑 ３小便深黃 ４排氣少 ５雙足溫 ６口渴還好 ７睡不好，時醒。 ８身時熱時冷 ９無月經了，仍有子宮卵巢等在 １０中午以後會潮熱，下午痛變嚴重 １１有胃酸反逆
脈診：緩有力
望診： 1、**舌診：**舌淡黃濕 2、**眼診**：
特殊診斷：
耳診：
診斷： 中焦濕熱，因ＡＣＩＤ
針灸處方：
中藥處方： 旋覆花三錢　代赭石五錢　生薑三片　大棗十枚　石膏四兩　知母五錢　澤瀉五錢　當歸二錢　側柏葉三錢　枳實三錢　豬苓三錢　瓜婁實五錢　桂枝三錢　海藻四錢　茯苓三錢 伍付　九碗煮三碗水　早晚飯前
解說：此例已接近胰臟癌。 １代赭石重鎮降逆為主藥，因有胃酸故加重。 ２炙甘草增膩故不用。 ３不用白朮因怕他胃口會更好。
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2000/01/14			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
BR	F	59歲 很胖	2008/08/21

來診原因：左肋痛減輕許多，可轉身了。胃酸下降，只剩一點點。臉頰紅如蝴蝶斑退去。倪師說此人為胰臟癌。

問診：
1大便未盡出
2小便中黃，比以前淡
3睡在凌晨兩點到三點醒來，之後可睡到天亮
4身熱退
5胃口好
6雙足溫
7不易出汗

脈診：比較好，細小

望診：
1、舌診：一點淡黃紅
2、眼診 :

診斷：

中藥處方： 同8/13加
厚朴二錢　大黃三錢　柴胡三錢　鬱金五錢　龍膽草三錢　茜草三錢
伍付　九碗煮三碗水　早晚飯前

解說：
1因大便未盡出故加大黃厚朴。
2丑時醒來，加柴胡鬱金龍膽草茜草
3胰臟癌病人幾乎百分之百便秘

備註：服藥完再來找我

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2000/01/14			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
BR	F	59歲 很胖	2008/08/27

來診原因：左肋下方仍有痛，但痛在縮小之後，仍有持續痛。痛時，小便就深。

問診：
1大便好轉，二次一天
2小便時深時淡
3睡好轉許多（兩三點醒來，立即可回睡）。
4下午潮熱退許多。

５胃口好，仍無汗出。 ６臉紅蝴蝶斑退許多。 ７胃酸好了不反逆。 ８甲狀腺稍腫（無心悸）。 ９雙足溫 １０手溫頭熱手背涼下。
脈診：緩有力
望診： 1、**舌診：**淡黃紅 2、**眼診**：
特殊診斷：
耳診：
診斷：　病人進步許多
針灸處方：
中藥處方：　同8/13加 厚朴二錢　大黃三錢　柴胡三錢　鬱金五錢　龍膽草三錢　茜草三錢 伍付　九碗煮三碗水　早晚飯前
解說： １胰臟癌病人一定要大便通暢，同時顧肝。 ２因為體溫夠熱，所以不用擔心甲狀腺有不好的問題，而且沒有心悸，故不是甲狀腺的問題。
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/05/06			
姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**
BS	女	18歲, 嬌小身材	2008/08/19
來診原因： 焦慮, 有低血糖証, 輕微頭痛, 倦怠, 心悸(不規則跳動), 手抖。			
問診： 睡眠：好, 不易入眠。 月事：正常。 大便：每日一行, 時不易出。 小便：淡黃。 雙足溫度：雙足冷。 手額溫度：手指冰, 額頭熱。 身溫：身體時冷時熱。 口渴：　冷飲。 胃口：　一直是餓的。			

出汗：半夜盜汗。
脈診：脈小細緩, 右大于左
望診： **1、舌診：**舌苔淡黃, 舌紅
診斷： 心血不足，上熱下寒。
中藥處方： 石膏三兩 知母五錢 炮附子四錢 細辛二錢 桂枝四錢 炙甘草五錢 白芍四錢 龍骨三錢 牡蠣六錢 大棗十枚 黨參三錢 熟地二錢 阿膠三錢 (分三次烊化) 麻子仁三錢 麥冬三錢 5付 9碗 →3碗 早晚飯前各服 1碗
解說： 1石膏、知母→降胃熱 (胃口太好) 2桂枝、炙甘草→心臟動力不足(手指冰) 3炮附子、 細辛、白芍、炙甘草→下焦寒(雙足冷) 4龍骨、牡蠣→ 潛陽(手指冰, 額頭熱) 5 桂枝 、炙甘草、大棗、黨參、熟地、阿膠、 麻子仁 、麥冬 → 炙甘草湯→補心血 (心悸, 不易入眠) 6 右脈大于左脈→氣勝血是男人正常脈, 女人正常脈應該左大于右 7因他會很餓故勿用生薑再刺激他的胃。 8此女的心熱無法到小腸只能到胃，故胃熱胃蠕動快因此他易餓。 9此女的心熱無法下到小腸故反逆於上而造成肺熱，肺有熱而魄不能靜故焦慮 10心熱若能下到小腸，則小腸熱了以後腎也會熱，則焦慮會除。

倪醫師病案紀錄	初診日期：1999/11/10
姓名	**性別：**
BW	男
來診原因： 血壓高 280/120。 頭痛。雙肋痛(外側)。 右側環跳痛(切片後)延足少陽膽經上下。	
問診： 胃口：不大, 因一直噁心。 你血壓高時有何不適？答：有時會嘔吐, 如心臟要跳出。 雙足溫度：雙足冷且麻木。 身溫：無身熱。 口渴：口渴重, 喜冷飲。 出汗：不易出汗。	

小便 ： 淡黃。
大便：平平。
8、 睡眠：失眠。

脈診：脈洪大

望診：
1、**舌診：**白濕厚。→主寒濕，此乃典型的腎臟不好之舌象(快腎衰竭了)
2、**眼診：**瞳孔無反應, 肝區有褐點。

耳診：

診斷：心陽不足 腎陽虛 陰不入腎。

針灸處方：
左(俠溪, 申脈), 雙(足三里 , 太衝)。

左束骨, 右環跳(呼吸補法, 不留針)。

中藥處方：
1.
生附子三錢 乾薑二錢 炙甘草五錢
桂枝五錢 白术五錢 澤瀉五錢 茯苓五錢 豬苓三錢
半夏三錢 補骨脂三錢
白芍八錢 炮附子四錢 川芎三錢
柴胡三錢 鬱金五錢 龍膽草三錢
5付 9碗 →3碗 早晚飯前各服 1碗

解說：
1生附子 乾薑 炙甘草→四逆湯→壯心陽
2桂枝 白术 澤瀉 茯苓 豬苓→五苓散→利濕
3柴胡 鬱金 龍膽草 →清肝助睡眠
4白芍 炙甘草 炮附子 川芎→ 芍藥甘草附子湯→雙足冷且麻木
5補骨脂 澤瀉→補腎陽
6豬苓利下焦水，患者小便還通時就不用，若欲強攻腎臟與膀胱積水時就重用

備註：
1 此人對西藥過敏, 故無法吃降壓藥。

倪醫師病案紀錄 初診日期：1999/11/10

姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**
Burby Wade	男	中年, 肥胖	2008/08/27

來診原因：
血壓高。

問診：仍有一付藥未喝 血壓下降很多，平均156/91。 雙足溫度：足冷退，口渴較前減少，現在較不喜冰飲，較喜溫飲。 體力仍差。 胃口：惡心好了。 5、 睡眠：睡好多了，無頭痛了。 6、 小便量增多。 7、足冷且麻，會因此睡到一半醒來。
脈診：脈緩有力。
望診： 1、**舌診：**白厚淡黃。 2、**眼診：**
耳診：
診斷：進步中。
針灸處方：
中藥處方： 1. 同前方。改生附子二錢 。余同。 6付 9碗 →3碗 早晚飯前各服 1碗
解說： 血壓從280/120降至156/91。 病情好轉，逐漸減少生附子劑量。 腎不好故肺水無法入腎，水積於中焦故噁心

備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/8/20			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
CB	女	70歲，體胖	2008/08/27
來診原因：回診，血糖300以上。			
問診： 睡好些 胃口仍好 大便每日行 雙足溫許多 口渴有，喜冷飲 小便頻數，顏色中黃到淡黃 體力還好 身體很熱感			
脈診：脈稍洪有力			
望診： 1、舌診：黃乾 2、眼診 :			
診斷：　裡熱仍有，上熱下寒			
中藥處方：石膏六兩　知母五錢　炮附子四錢　杏仁三錢　天花五錢　生地三錢　白芍六錢　烏藥五錢　補骨脂三錢　益智仁三錢　澤瀉三錢　厚朴二錢　枳實二錢　大黃三錢　五付　九碗水煮成三碗，每天早晚飯前各一碗			
解說： 1喜冷飲，身體仍覺很熱→石膏加重 2雙足溫許多了且小便黃知下焦寒有轉熱→去細辛 3炮附子、白芍是讓其足循環好點			
備註：			

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/26			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
CC	女	39多歲，中等身材，略胖	2008/08/26
來診原因：自述被西醫判定成憂鬱症，自殺過一次。先是因毫無睡意而失眠，吃安眠藥後憂鬱，西醫給予抗憂鬱藥後(已服八年)不知為何地想自殺，已自殺過一			

次。月經準時，但每次來只有一天，且色黑，此狀況已持續五年。

問診：

（1）睡眠：睡不著，毫無睡意。
（2）口渴：不停喝水，喜溫水，不喜冰水。
（3）胃口：好。
（4）大便：每日一行，一天三次，下利清穀。
（5）小便：時白時黃淡，一天小便十餘次。
（5）手足：雙足冰、手冷。
（6）出汗：不易出汗
（8）月經：準時，五年來每次月經來都只有一天，經血色黑。
（4）其他：一緊張就想吐(吐水)及想尿尿，自殺過一次，小腿癢。

脈診：脈沉細無力

望診：

1舌診：苔黃濕，舌右側有藍紫瘀塊
2眼診：肝區有洞和圈紋，肺白有明顯黃塊、腎區反應不好。

耳診：無

診斷：心血不足，腎陽虛，心陽不足

針灸處方：

中藥處方：

一、
桂枝五錢、炙甘草五錢、黃連二錢、黃芩三錢、
白芍五錢、阿膠三錢(分三包，烊化)、
吳茱萸二錢、乾薑二錢
巴戟天三錢、補骨脂三錢、生薑二片
當歸二錢、細辛二錢、生附子三錢(布包)
遠志五錢、鬱金五錢、柴胡三錢
五付，每付用九碗煮成三碗，早晚餐飯前服用。
二、HT-71(中安丸)，六兩，中餐及睡前各四十粒。

解說：

心陽不足用桂枝甘草，辛甘為陽藥，心血不足用連芩，苦味補心。
巴戟天以補腎陽為主、補骨脂以補腎陰為主。
大便已經一日三次，故當歸四逆湯架構去木通。
遠志令人鎮靜，柴胡鬱金舒解心情。
肝排毒時，會大黑便及皮膚癢，此女的小腿癢屬肝排毒素。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/21

姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**
CD	女	49岁 中等偏胖	2008/08/21

來診原因：

左肋痛，左下腹痛，吃任何东西就呕吐下利

甲状腺病仍亢进，胸口痛，手冷冰

問診：
睡眠：不好，倦怠
寒热：身恶寒，无汗，但一工作则多汗
二便：大便出多，下利，仍见清谷，味重
胃口：有，但怕吃，食后即恶心
口渴：有，喜温饮
双手足：冷
其他：下雨则关节痛

脈診：右脉沉小无力，左脉稍大于右

望診：

1、**舌診：**白湿

2、**眼診** :

特殊診斷：

耳診：

診斷：寒湿在四肢及胃中，肠中又多湿热兼一点寒，少阴证

針灸處方：

中藥處方：
炮附子 四钱 生姜 二片 白术 三钱 吴茱萸 三钱 干姜 二钱
炙甘草 五钱 桂枝 五钱 旋覆花 三钱 代赭石 五钱 大枣 十二枚
党参 三钱 麻黄 三钱 细辛 二钱 海藻 四钱 牡蛎 五钱 黄柏 三钱
黄芩 三钱 五付 9-3碗 早晚餐前服，每服半碗

解說：
麻黄附子细辛汤：主少阴证，脉沉小，倦怠。
四逆汤（炮附子、干姜、炙甘草）：身恶寒，手足冰冷，下利清谷
甘草附子汤（炙甘草、炮附子、桂枝、白术） 去风化湿散寒逐四肢关节弊痛，因患者下雨关节痛，无汗，动则汗多。
吴茱萸、干姜， 温胃散寒；旋覆花 代赭石，降逆止呕

黄柏、黄芩：清肠中湿热，止利

海藻 牡蛎：软坚散结，疗甲状腺病
7、倪師曰：四逆湯原方為生附今改炮附，因為病人屬少陰證，但又兼肺家寒證。

倪醫師病案紀錄	初診日期：2008/08/07		
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：

CE	男	13歲，中等身材	2008/08/07
來診原因： 長期氣喘仍有一些，對寵物過敏			
問診： 大便一日2、3次，下利多→代表肺中有很多痰水，一動痰水跑到下面腸子去就下利 運動後有時想吐 早上起床或游泳後會暈眩 有汗出 睡眠好			
脈診：脈浮數			
望診： 1、舌診：淡白紅 2、眼診 :			
特殊診斷：			
耳診：			
診斷： 肺中寒濕			
針灸處方：			
中藥處方： 射干麻黃湯 400粒 8x3 三餐飯前服用			
解說： 射干麻黃湯→久咳久喘，去水去痰			
備註：			

倪醫師病案紀錄	初診日期：2008/8/4		
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
Cf	女	76歲，略瘦	2008/8/4
來診原因：氣喘、 頭痛、 頭暈無惡心 、搖頭不止（有吃鎮靜藥）、手也抖，昏倒時嘔吐更重，見光則吐 甲狀腺亢進十幾年（沒吃藥）			
問診：1吐氣困難（肺有問題） 2不噁心 3睡眠還好 4見光就想吐（陽虛） 5口渴還好→師問他口渴否，乃欲查其體內津液狀況，因欲採吐法之前需知其體內津液是否足夠。 6痰很多 7大便一天一次（軟） 8胃口尚可			

脈診：寸關有脈且數，尺部無脈
望診： 1、舌診：淡黃濕 2、眼診 ：
耳診：
診斷：病在上（痰飲之固痰），採吐法
針灸處方：
中藥處方： 藜蘆2錢 炙甘草3錢 大棗10枚 生薑2錢 麻黃2錢 射干3錢 紫菀3錢 款冬花2錢 杏仁2錢 3 帖 9碗水煮成 3 碗 早晚飯前各一碗
解說：1.藜蘆甘草湯用來吐痰 射干麻黃湯開肺氣 2.昏倒時嘔吐更重，見光則吐→因光是陽，他陽虛，故見光則吐 3.搖頭不止（有吃鎮靜藥）、手也抖→此乃有風有痰
備註：藜蘆可以去經脈上的痰。 採吐法前，要確定病人胃中有無津液（口不渴、才可吐） 此為金匱中的趺厥病

倪醫師病案紀錄	初診日期：20080807		
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
CH	M	中年，高瘦	20080807
來診原因：心悸有偶爾一次，自發作時比以前好，有過敏（貓）引起氣喘，春秋時鼻炎重，症狀為自喉開始咳，嚴重的則喘（清痰）			
問診： １口渴還好，室溫水 ２胃口好 ３雙足涼 ４睡好 ５大便每日有，一日一行 ６有時有脫肛 ７運動汗較多 ８不胸悶 9 情緒易不好			
脈診：浮稍短			

望診 1、舌診：黃濕 2、眼診：
特殊診斷：
耳診：
診斷：
針灸處方：
中藥處方： 桂枝５　炙甘草３　黃連２　黃芩３　升麻３　麻黃３　射干２ 紫苑２　冬花２　生薑１　半夏２　炮附子２ 膠囊４００粒　８ｘ３　三餐飯前
解說：此例可捨脈取證，桂枝甘草湯治心悸，射干麻黃湯治久咳化痰水，炮附子收斂固表，(炮附子可治狐臭疝氣脫肛等)。脫肛就是上焦肺的力量不夠，故加升麻提升中氣。
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：２００８／０８／２５			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
CJ	男	51歲，略瘦	2008/08/25
來診原因： 1981年起有B、C型肝炎，病人無C肝抗體，之後形成肝硬化。兩年前得糖尿病，小腿水腫有六個月了。 自述皮膚一碰即破→西要造成的，很多年不流汗了，且常抽筋。			
問診： 1.小便：深黃，近紅，量少，日間次數少，晚間頻尿而色清。 2.胃口：好。 3.大便：每日行，有時便如黑油。 4.睡眠：易入睡，因尿而醒。 5.手足額身：手足冷，睡時身冷，額熱 6.午後有潮熱。 7.口渴：渴而不欲飲。 8.血糖指數：飯前150-200;飯後200-300。血糖高時感到頭昏身體怪怪的，手部有少許麻，也試過日間無故昏睡，拍也不醒。 9.體力：好。 10.脇肋：非持續的脹痛或刺痛感。 11.雙足麻			
脈診：尺脈大於寸			
望診：臉黧黑，為主色，細看帶青、黃。胸肋間皮膚有血絲。 1、舌診：淡白紅			

2、眼診 ： 肝區多白點，圈紋擠得很密。
耳診：
診斷： 裡寒、陰寒。
針灸處方： 左前臂肝關（腕圓骨上６寸，從外側入針） 三皇穴 足三里 大腿內側肝病奇穴壓痛點 章門 期門 翻身針肝俞 腎俞 脾俞
中藥處方： 生附子二錢 乾薑二錢 炙甘草三錢 柴胡三錢 玉金五錢 茵陳三錢 白朮三錢 梔子三錢 天花粉三錢 熟地三錢 澤瀉四錢 烏藥三錢 細辛二錢 桂枝四錢 茯苓四錢 茜草三錢 炙鱉甲三錢 白芍五錢

解說：
1.病人臉黑帶青黃，是腎、肝、脾三臟同病之證。尺脈大於寸、午後潮熱、夜尿頻，頭熱手足冷，四者共證陽不入陰。故用生附處理裡寒及陰寒，使陽能入陰。又以柴胡、玉金、茵陳、入肝舒解氣鬱；以茜草、鱉甲入肝攻血鬱。病人渴而不欲飲，是內有瘀血之證，故攻之。為防入肝之力不足，加大劑白芍使藥隨血歸肝。凡治肝硬化，必用白芍。又以熟地、澤瀉理腎。以白朮、茯苓理脾。因足冷、夜尿頻故用烏藥細辛移心熱於小腸。因心陽已傷、無汗故重用桂枝、炙甘草，但他有腿腫而炙甘草會蓄水，因此若下次來診腿仍腫則炙甘草要去之。因有虛熱於上焦故用梔子、天花。 2.針術方面：當以瀉南補北為指引。因肝於右，故只針左肝關。因小腿水腫，針三皇穴及足三里。 3.凡肝病當針肝病奇穴，以壓痛點下針為準。三臟同病故針臟之會穴章門，肝硬化故針肝募期門。背針三臟之俞穴則不待一二言矣。 4.另外病人胸前脅肋區有血絲，提示有肝癌肝硬化，反之亦然。 5. 他小腿腫跟打胰島素有關。若是本身疾病造成腳水腫則危險，因為男人怕腳腫。若是吃西藥造成腳水腫，一般不危險，停藥即恢復。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/8/19			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
CJ	M	42歲,體型壯碩	2008/8/19
來診原因： 左膝痛（開過刀）。 雙側腰眼部位痛。 平素喝酒過量。 倦怠、沮喪。 皰疹病史，服西藥中。 失眠、慢性鼻炎。			
問診： 大便每日一次，但不定時。 胃口不好。 口渴有，喜溫飲。 小便淡黃。 雙足冷。			
脈診：洪數中空，一息六至（酒客病）。			
望診 舌診：白濕厚（中焦濕）。			
診斷：清肝活血強腎。			
針灸處方： 左膝五針（陽陵泉透陰陵泉《平補平瀉》、鶴頂、膝眼）治療膝痛。 雙側委中及委中到承山間的壓痛點。（若把委中視為對應腰部、承山視為對應股			

部《承山可治療痔瘡》，則兩穴間即對應到腰臀間部位。病患主訴腰眼附近痛，在此兩穴間的膀胱經循行附近找痛點，此即為阿是穴《天應穴》，本法可精準找出相應痛點，針去痛癒。）

中藥處方：

柴胡三錢 玉金五錢 黃芩三錢 龍膽草三錢 茜草三錢
酸棗仁三錢 白芍六錢 辛夷三錢 菖蒲三錢 蒼朮三錢
補骨脂三錢 巴戟天三錢 澤瀉五錢 女貞子三錢 炮附子四錢
龍骨三錢 牡蠣五錢

五帖，9碗水煮成3碗，早晚餐前各服1碗

解說：

柴胡、玉金、黃芩、龍膽草、茜草清肝中毒素，酸棗仁助眠。白芍能清肝且清除瘀血，也可對他的膝痛活血化瘀，故加量用

辛夷、菖蒲治慢性鼻炎，蒼朮配澤瀉可除濕解酒，補骨脂、巴戟天補腎，加澤瀉平衡補瀉，女貞子潤肝。

雙足冷以炮附子暖下焦，龍骨、牡蠣配酸棗仁安神助眠。酸棗仁可使血歸肝，魂歸肝則可眠。

倪醫師病案紀錄 初診日期：2008/08/19

姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**
CJ	男	42, 健壯	2008/08/26

來診原因：

憂郁。

問診：

睡眠：4:00AM醒。

有咳嗽。
鼻炎。

大便：稍利。有時一天兩次。

胃口：好轉。

雙足 ：溫。

口渴：尚好。

脈診：

望診：

1、舌診：淡白黃紅。

2、眼診：

耳診：

診斷： 進步許多。

針灸處方：

中藥處方：

同前。改菖蒲四錢 蒼朮四錢 加半夏三錢 五味子三錢

10付 9碗 → 3碗 早晚飯前各服 1碗

解說：

1菖蒲 蒼朮 → 去鼻濕。

2半夏 五味子→ 化痰止咳。

備註：

停止吃奶制品。

倪醫師病案紀錄	初診日期：		
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
CJ	男	約40歲，中等	2008/8/12

來診原因：左肋偶爾痛一下，飲酒造成。血中酸過多，BP 148/98，乾眼症，左足胆經上丘墟麻，鼻炎。

問診：

睡眠：尚好。
身温正常。
大便正常。
小便中黃。
口渴尚好。
雙足冷（很久了）
易出汗。
手冷足冰(自知)額熱

脈診：脈緩
望診： **舌診：**黃乾厚。 **眼診　：**脾區過大，肝區有破損且圈紋多(圈紋代表有脂肪肝)，瞳孔對光反應差→腎陽不足。
特殊診斷：
耳診：
診斷： 脾受損，酸剋甘，腎陽不足，心陽亦不足。
針灸處方：
中藥處方： 桂枝五錢　白芍五錢　旋覆花三錢　代赭石三錢　生薑三片　乾薑二錢　當歸二錢　木通二錢　黃芩三錢　細辛二錢　蒼朮三錢　澤瀉五錢　炮附子四錢　補骨脂三錢　敗龜板二錢　辛夷三錢　菖蒲三錢　玉金五錢 五付 9—3碗 早晚餐前各一碗

解說：
當歸四逆湯去炙甘草→治手足厥冷，炙甘草增膩故去。 旋覆花三錢　代赭石三錢→治嘔酸。 生薑温中，乾薑散水。 大便好木通用二錢即可。 蒼朮三錢　澤瀉五錢→解酒毒。 炮附子四錢　補骨脂三錢　敗龜板二錢→補腎陽。 辛夷三錢　菖蒲三錢→鼻塞。 玉金五錢→病人近日喪父，壓力大。 老師告知病人，當手足温度回升就表示病已轉好。
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/06/09			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
Coulter John	M	年齡不知，體格壯碩	2008/8/20

來診原因：

酸血症（Acidic blood）、高血壓（平素約148/98mmHg）。
左肋下偶而疼痛，飽滿造成。（病患平時有喝咖啡）
鼻炎好。
左足丘墟處痛（膽經）。
自覺手足冰冷。
病患尚有一帖藥未服，提前就診。

問診：

夜間睡眠因夜尿有一兩次醒，但可回睡。
左肋痛仍有一些。
鼻炎已無症狀。
雙足仍冷。
小便淡黃到中黃。
體力好。
胃口好。
口渴尚好
血壓155/101mmHg（未服降壓西藥），病患有吃一些起司及冰淇淋。
身時出汗，皮濕。

脈診：脈弦有力。

望診

舌診：黃白厚濕。

診斷：表虛裡寒。

中藥處方：

同2008/08/12處方，炮附子加重至六錢（原來四錢）
四帖，9碗水煮成3碗，早晚餐前各服1碗
★前次剩餘的一包藥再加入二錢炮附子

解說：

本病患脈象弦數，且夜間無特別寒熱感，並非生附子適應症，故不用之；而病患較無改善及較不穩定之症狀與表虛裡寒較有關，因此守方並以加重炮附劑量治療裡寒兼固表。
倪師衛教：不可喝牛乳及所有相關乳製品。

備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2006/09/07			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
Coulter, John	F	約四十歲，身壯	2008/08/27

來診原因：

胰臟癌複診

問診：

1. 睡眠好
2. 左肋痛去
3. 小便淡黃
4. 雙足仍有冷
5. 胃口好
6. 大便每日行
7. 口渴正常
8. 睡時無寒熱
9. 體力尚好

脈診：稍洪大有力

望診

舌診：黃白乾厚→燥熱，寒熱並結

診斷：病人進步中

中藥處方：

同8/12 方, 改砲附子六錢　麥冬三錢　天花三錢　黨參三錢　五付

9碗煮成三碗，早晚餐前各服一碗

解說：

1. 治胰臟癌一定要注意大便
2. 左側肋下持續痛是胰臟癌，偶爾會痛是胰臟炎.
3. 舌: 黃白一寒熱並結，乾一津液燥，厚一燥區大
4. 天花可增加血中的津液, 麥冬增潤肺的津液, 黨參增加腸胃津液
5. 病人右臉下方稍腫大, 師觸診後告知, 因無腫塊又無熱, 無須擔憂.

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
CK	女	40　中等	2008/08/13

來診原因：四個月前開刀切除一在左眉上方的腫瘤，之後被診斷為癌(一種慢性成長的癌)。其額頭的腫塊自2000開始即有。之後用西藥Gleevec三個月，讓她非常不適，失眠，憂鬱，倦怠，嘔心。

問診： 月經提前來，這一次21天(以前不記得了)。 每次月經來人就很憂鬱。 大便三天一次。 小便中黃。 排氣無。 雙足冷，手溫。 口渴有，喜冷飲。 下午以後身熱加重，睡時身熱。 前額手術處無痛或輕痛。
脈診：脈細小無力
望診： 1、舌診：淡白黃，苔薄，牙痕多 2、眼診：
耳診：
診斷：　上熱下焦也熱，寒熱並結。
中藥處方：　黃連兩錢，黃芩三錢，白芍五錢，阿膠三錢分三包(烊盡)，厚朴兩錢，枳實兩錢，大黃三錢，芒硝三錢分三包(沖服)，玉金五錢，柴胡三錢，天花三錢，麥冬三錢，半夏三錢，乾薑兩錢，陽起石三錢。服時加蛋黃一只入內沖服。
解說： 主方為黃連阿膠湯加大承氣湯。 額頭屬陽明，大腸亦屬陽明。大腸便秘產生燥氣故額頭長腫瘤。 因不確定脈細小是否為寒，故先不開大量熱藥。 心火受肺氣之肅降移熱小腸，今病人上熱，必使肺太過乾燥，就像車子的radiator缺水，故用潤肺之藥，亦用疏肝之藥。
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/13			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
CK	F	40歲 身形瘦	2008/08/26

來診原因：
腦瘤複診

問診：
1. 大便: 正常
2. 情緒: 好轉
3. 睡眠: 不好, 吃了三天的安眠藥
4. 足溫: 已溫許多
5. 體力: 好
6. 體溫: 下午熱退許多

脈診：脈緩無力　不細了

望診
舌診: 淡白紅

診斷：病人進步中, 但出現虛熱, 血不歸肝.

中藥處方：
同8/13 方 加酸棗仁三錢　知母三錢　麥冬三錢
改大黃兩錢　芒硝兩錢（ 各減少一錢 ）九碗煮成三碗　早晚餐各服一次

解說：
1. 少陰症漸退
2. 加酸棗仁　知母 → 使血歸肝, 能入睡.

倪醫師病案紀錄　　初診日期：２００８／０８／２６			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
CL	男	48歲，瘦小	2008/08/26

來診原因：
多發性骨髓瘤及鼻咽癌。做過多種切片，也服過西藥治療。病人是素食者，自述已無晨舉。

問診：
1.睡眠：無法一覺到天亮。
2.手足寒熱：手足多冷，冬天尤冷。
3.胃口：還好。
4.口渴否：不會。
5.大便：有時便秘，有時每日行。
6.體重：下降中。

7.體力:自六月中證實頸部淋巴結腫大實為鼻咽癌後，體力下降，且右耳聽力衰減。
8.汗： 非常易出汗。
9.身體寒熱感覺：中午以後身是冷，夜睡時身亦冷。

脈診：脈沉細有力。有附骨，但不數。屬陰實

望診：
1、舌診：白乾舌，質暗紅。
2、眼診 ： 腎區幾無反應，肺區多痰濕，肝區積毒，已無圈紋。

耳診：

診斷： 裡寒重症。

中藥處方：
生附子三錢 乾薑二錢 炙甘草四錢 龍骨五錢 桂枝四錢 白芍四錢
當歸二錢 木通三錢 細辛二錢 牡蠣一兩 絡石藤四錢 陽起石三錢
瓦楞子五錢 炮附子五錢 生薑二片 防己三錢
2 帖 9碗水煮成3碗 早晚飯前各喝一碗

解說：
凡遇骨中腫瘤，用當歸四逆湯必效。病人口不渴，證為裡寒。加四逆湯去裡寒，生附重用至三錢。病人午後身不熱，證明陰陽格拒只在三焦，尚未內陷至臟，若陰實至於臟腑，身必潮熱。乃以防己為使，帶領牡蠣、瓦楞子入三焦腺體以攻堅。凡喉頸舌之陰積，須得絡石藤開其閉。病人自述不舉，腎區無反應，用陽起石振興腎陽。病人易汗，非心力足也，實為表陽虛津液不守，無力固表，故用炮附固表。

倪醫師病案紀錄 初診日期：

姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
CM	女	約50歲，瘦	2008/08/12

來診原因：
此即迪士尼執行長，初診時手指與手腕的關節嚴重變形，持續服HT-100，此次回診。

問診：
左眼過乾，但視力好轉
右手無名指又生一硬節(類風濕)→近風寒濕三痺
查關節冷冰
自述非常不易出汗

脈診：沉緩有力

望診：
1、舌診：
2、眼診 ：

特殊診斷：

耳診：

診斷： 可用汗法

針灸處方： 1雙：合谷、養老、睛明 2美容針
中藥處方： 1回吃HT-100(自己仍有一罐)　早晚飯前各吃30粒 2桂枝四錢 白芍四錢 麻黃三錢 杏仁三錢 炙甘草三錢 大棗十枚 生薑二片 白朮三錢 決明子五錢 生地二錢 女貞子三錢　五付　九碗水煮成三碗，每天早晚飯前各一碗
解說： 1美容針→用「擔法」：每條皺紋中間斜刺，淺針，針倒、留針 2 HT-100(歷節丸)→烏頭湯 3中藥處方2為麻黃湯+甘草附子湯去炮附子(無汗)+補眼(決明子)+補肝腎(用水生木：生地、女貞子)
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2007/11/21			
姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**
CP	F	47歲，中等身材微胖	2008/08/11
來診原因： 初診時為Barrett's disease及鼻過敏。（目前鼻過敏已無發生） 本次就診為胃部時仍不適，偶而仍想吐，走路後若有打嗝則症狀緩解。 早上5:30會熱醒。 食道中間時痛，過去伴隨聲啞，現在聲音已好轉。 時欲咳嗽。 解尿時有時刺痛。 稍說話即咽啞。			
問診： 每日排便，大便呈淺咖啡色。 會餓。 月經正常，但偶提前偶延後。 雙足溫。 夜間睡時身溫。			
脈診：沈細小，無力。（寸上寸無附骨脈，咽喉無癌症。）			
望診： **舌診：**淡白紅。			
特殊診斷：穴位診→按壓太谿穴附近疼痛明顯。			
耳診：腎結石點按之疼痛。			
診斷：膀胱結石，胃家寒證，腎陽不足。			
針灸處方： 雙腿腎結石點（阿是穴按痛點下針）。			

右列缺、雙照海→治療咽痛，病患下針後食道中間痛感立去。（正列缺下針處位置位於脈診尺部後方，撥開脈後針於脈下。）
中藥處方： 厚朴二錢 蘇葉二錢 夏枯草五錢 絡石藤三錢 吳茱萸二錢 乾薑二錢 半夏三錢 豬苓三錢 滑石四錢 澤瀉三錢 阿膠三錢（分三包，烊盡） 麻黃二錢 炮附子三錢 細辛二錢 麥冬三錢 西洋參三錢 先給粉劑100粒，8/13複診針灸時再給十帖湯劑

解說：
Barrett's disease是遠端食道粘膜的鱗狀上皮被柱狀上皮所替代的病變。這種病變被認為是反逆性胃食道疾病的併發症，並因其會發展成食管癌而受到注意。本病大多數病人常會主訴胸骨後灼熱感、疼痛、消化不良、嘔吐物或糞便中帶血、吞咽固體食物困難，以及夜間熟睡時胃內容物逆流。 病患之脈象為沈細小無力，此為腎脈，而「腎主喉嚨，腎病發於喉」，故產生上述食道痛症狀，而解尿時刺痛為腎結石症狀，師以針刺緩解疼痛，以處方治療。腎主雙腿，同時囑咐病患可藉運動護腎，加強下肢功能。 方義：厚朴、蘇葉行氣，夏枯草、絡石藤治療咽喉食道腫脹，吳茱萸、乾薑溫中止嘔，豬苓湯利小便，麻黃附子細辛湯治少陰證（憑脈），麥冬、西洋參滋陰生津治咽啞。
備註：

倪醫師病案紀錄	初診日期：2008/08/26		
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
Cs	F	70歲　152cm 72kg	2008/08/26

來診原因：肝硬化五年多，腹水，半個月前胸腔積水在肺，靜脈擴張，脾腫大，腎衰竭，尿液排出越來越少。胸腔靜脈結紮怕吐血。
抽水兩次，隔了兩年多。有用利尿劑。沒喝酒。

問診：
１小便量少，尿意有，半夜尿多，清晨也多，白天沒有。→子時以後陽要出來陰要退，故小便多。白天無代表腎不好，但還未衰竭。
２呼吸短（肺積水）
３胃口好，味覺好
４口渴有，口苦，欲飲溫開水
５大便一天二三次，一吃就想上廁所
６最近體重上升，小便茶色深
７雙足冷，身體是熱的（上半身熱下半身冷），午後無潮熱。
８睡不好，１－３點有問題。
９在台灣流汗多，在加州無汗出。
１０沒有痛感。可平躺。

脈診：右脈稍弦數，左脈無（摸不到，反關脈亦無）

望診：腹部出現肝硬化特有血絲，腹大積水，頭髮膨鬆乾無油。
1、舌診：舌紅無苔
2、眼診 :

診斷： 上假熱下真寒

針灸處方：
雙公孫　雙內關　雙三皇　水分　關元　水道　中脘　巨闕　雙足三里
雙心俞　雙肝俞　雙脾俞　雙腎俞

雙承山→腳會抽筋。
中藥處方： １胃苓湯　200粉量　早晚飯前各三茶匙 ２生附子（另包）三錢　乾薑二錢 麻黃三錢　射干三錢　紫菀三錢　冬花二錢　麥冬二錢　知母三錢　生薑二片　烏藥三錢　補骨脂三錢　澤瀉三錢　茯苓三錢　厚朴二錢　陳皮二錢　柴胡三錢　鬱金五錢　茵陳三錢　茜草三錢 五付　九碗水煮三碗　一天兩碗

解說：
1因病人腹水故四逆湯中去炙甘草不用。 2射干麻黃湯排肺中水氣。過去無心臟病故可放心用此方。 3腹脹故用厚朴陳皮等平胃散加減。 4熟地為滋陰藥，會蓄水，改補骨脂。 5治肝之病當先實脾，脾土不能制水則影響到腎，腹大水腫。腎會影響心，但症狀不明顯，現在心已經影響到肺造成肺積水了。 6請問為什麼射干麻黃湯沒有細辛？為什麼用了射干麻黃湯還要用麥冬知母？
備註：鹽盡量少吃。禁食乳製品。楊桃不可吃。太冰的飲食不要吃。每晚泡蔗糖水喝避免抽筋。

倪醫師病案紀錄	初診日期：2008/08/26		
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：

Cs	F	70歲　152cm 72kg	2008/08/29
來診原因：轉診加州其他醫師			
問診： １小便仍量少，喘，腹滿 ２足熱→藥有到			
脈診：			
望診： 1、舌診： 2、眼診 :			
特殊診斷：			
耳診：			
診斷：			
針灸處方： １雙公孫　雙內關 ２雙三皇　水分　關元　雙水道　中脘　巨闕　足三里　心俞　肝俞　脾俞　腎俞　雙承山　雙章門　雙期門			
中藥處方： １補氣治濕湯　600粉量　三餐前三茶匙 ２同前方　五付 ３四神湯　10包　每次一包，先泡水一小時再文火煮爛當點心吃			
解說： １肝病腹水甘淡滲利可用四神湯＋蔗糖，蔗糖甘緩解決抽筋。 ２肝病腹水若是實證，病人氣色好聲音洪亮，可用分消湯。 若氣色暗，講話虛弱為虛證，用補氣治濕湯，裡面有人參可補氣。			
備註：			

倪醫師病案紀錄　　初診日期：20071121			
姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**
CW	F	17歲 過胖	20080811
來診原因：患者未來診，由母親代診：焦慮，強迫症，不易出汗，過胖，情緒不穩，月經延後，偶爾又三週來一次，鼻塞仍有，尤其春天連眼也會。			
問診：			
脈診：			
望診： 1、舌診：			

2、眼診 ：
特殊診斷：
耳診：
診斷： 裡熱不出，汗無透發，故產生強迫症。
針灸處方：
中藥處方： 桂麻各半湯　逍遙散 １桂枝五錢　白芍五錢　麻黃三錢　杏仁三錢　炙甘草三錢　生薑二片　大棗十枚　辛夷三錢　菖蒲三錢　蒼朮三錢　遠志三錢　玉金五錢　柴胡三錢　黃芩三錢　龍骨三錢　牡蠣五錢 拾付　九碗煮三碗水　早晚飯前 ２HT-71六兩　清鬱開結丸　30x2　早晚飯前
解說： 桂麻各半湯透發其汗，逍遙散使其情緒穩定。
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2006/11/14			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
CW	女	32歲，微胖	2008/08/06
來診原因： 去年12月頭頂長一肉瘤，表面平滑。近來變大，白頭髮仍有、落髮多。			
問診： 睡眠：好 大便：一日2、3次，稀 胃口：過好 口渴：尚可 雙足較冷 易出汗，運動後汗出 近來大便軟，腸鳴多，易流鼻水 上身熱、下身冷 月經正常來，3天即止			
脈診：脈緩有力			
望診： 1、舌診：淡黃(微熱)乾(燥) 2、眼診 ： 左眼腎區反應不佳、肝區有圈紋(脂肪肝)及破洞			
特殊診斷：			
耳診：			
診斷： 肝積肥氣、左腎陽不足、燥熱、上熱下寒			
針灸處方： 肉瘤處用「暴刺法」			

中藥處方： 1柴胡三錢 玉金三錢 黃芩三錢 側柏葉四錢 當歸二錢 首烏三錢 石膏二兩 知母五錢 炮附子三錢 炙甘草三錢 大棗十枚 蒼朮五錢 辛夷二錢 菖蒲三錢 黃柏三錢 十付 九碗水煮成三碗，每天早晚飯前各一碗 熱藥冷服 2 HT-31澤蘭丸(欲減肥) 2罐6兩 30x2 早晚飯後各一碗
解說： 1炮附子→固表 2蒼朮→消頭頂肉瘤內之濕 3辛夷、菖蒲→流鼻水
備註：

倪醫師病案紀錄	初診日期：2008/08/06		
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
CX	女	43 中等	2008/08/06

來診原因：

2000年迄今，走路則氣短，上樓也喘，走長路常感到腰痛，西醫診斷為LAM-lymphangioleiomyomatosis肺淋巴管平滑肌瘤病，左背上有一大氣泡(肺區)。

問診：

吸入困難，一走快就感覺到。師曰，腎能納氣，吸入難為腎的問題。吐氣難為肺的問題。

睡不好，不易入眠，多夢，頭昏，夢都想到孩子讀書問題。

腰痛背後第五椎和第十四椎左右。心口如有重物壓。

胃口正常。

無口渴。

雙足冷冰，手冷。

無汗出，怕冷。肌肉關節無痛。

脈診：脈弦細無力→少陰脈

望診：

1、舌診：淡黃白濕

2、眼診 ： 左腎陽失，右腎還好，肝區損傷。師曰，腎不得肺津，久之連心也傷。

耳診：

診斷： 裡寒重之人

針灸處方：

中藥處方： 生附三錢(另包)，乾薑三錢，炙甘草五錢，生地兩錢，補骨脂三錢，桂枝五錢，枳實三錢，澤瀉五錢，麻黃三錢，細辛兩錢，炮附子三錢。

拾付，九碗煮三碗，早晚飯前服用。

解說： 生附，乾薑，炙甘草為四逆湯。 生地，補骨脂補腎。 澤瀉助腎排尿，用補劑時加一點瀉，讓腎喘息。 麻黃宣肺。 憂傷肺，告知病人要快樂。
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
DC	女	45岁 中等偏胖	2008/08/18
來診原因： 复诊，大便每日一、二次，胃不痛了，肛门无热痛了			
問診： 睡眠：好 二便：大便每日一、二次；小便中黄，量很好 胃口：好 口渴：无 双足：温 手热额热			
脈診：脉缓有力			
望診： 1、舌診：淡红干 2、眼診 :			
特殊診斷：两足肾结石点反应仍有			
耳診：			
診斷：胃肠恢复正常，仍有肾结石			
針灸處方：			
中藥處方： 汉唐26号 六两　每服30粒，早晚餐前服			
解說： 汉唐26号为猪苓汤加减→治疗肾、膀胱结石。			

備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/12			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
DF	男	60岁 肥壮	2008/08/12

來診原因：

偶尔会短气一下→師曰：可能是走路太快造成的，不要緊

問診：
睡眠：无法睡通宵，需照顾太太
胃口：好
口渴：无
大便：好，每日一行
小便：淡黄
寒热：睡时身热，手足温，手温额凉

脈診：脉大 有力（脉大，形体大，脉形相合）

望診：

1、舌診：淡黄白湿

2、眼診 ：肝区受损，但肝木润泽。

特殊診斷：

耳診：心区正常

診斷：过重、湿热造成

針灸處方：

中藥處方：
石膏 六两　知母五钱　防己五钱　猪苓三钱
　茯苓五钱　泽泻五钱 黄芩三钱　　十付 9 — 3碗 早晚饭前服
2、HT-63 六两 30粒 早晚餐后服

解說：

備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2007/09/26			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
EB	F	87歲	2008/08/08

來診原因： 乳癌復發，右乳過去傷口仍見出血。 7/28肺炎吃一週抗生素，出現二個新硬塊。 右眼靜脈血管問題，服用baby aspirin。
問診： １胃口好 ２大便很好，小便淡黃 ３口渴無 ４雙足溫 ５睡好 ６有汗 ７身溫無異常，偶而身熱一下 ８體力好 ９手冷額熱
脈診：關寸上焦脈洪大，有力，重按仍有，附骨脈
望診： 1、**舌診：**舌淡黃濕 2、**眼診**：
特殊診斷：
耳診：
診斷：上焦乳房陰實（癌症復發），真寒假熱。
針灸處方：
中藥處方：炒麥芽五錢　當歸二錢　川芎三錢　白芍五錢　熟地二錢　龍骨五錢　牡蠣一兩　陽起石三錢　桂枝五錢　炙甘草五錢　生硫磺二錢另包　茜草三錢　辛夷三錢　菖蒲三錢　知母五錢　赤小豆三錢　炮附子五錢　白朮三錢 貳付　九碗煮三碗水　早晚飯前
解說：生硫磺走三焦。知母和赤小豆去濕。炮附子合白朮為排膿湯。掌冷額熱為陽不入陰。Aspirin可用川芎等活血化瘀藥取代。
備註：下週二回診

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
EB	F	87歲　瘦小	20080812
來診原因：乳癌復發，仍有出血，胸不感到灼熱，不會痛，有時咳痰喉癢。			
問診： １藥力已到 ２無異常熱證 ３額小溫，手溫			
脈診：很好，無附骨脈			
望診： 1、舌診：舌黃厚乾 2、眼診 :			
特殊診斷：			
耳診：			
診斷：　同前			
針灸處方：			
中藥處方：　同前方 拾付　九碗煮三碗水　早晚飯前			
解說：咳痰喉癢因水氣上逆			
備註：			

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
ED	女	30+, 非常肥胖	2008/08/22
來診原因： 減肥, 少了45磅。77度的室溫, 覺得很舒適。			
問診： 睡眠：很好。 大便：時隔日, 因吃不多了。 口渴：有, 喜嚼冰塊。 小便 : 淡白。 身溫：全身都冷, 時又熱。 月事：服藥後, 月經即止。不吃, 月經直來不停。每次來9天, 停11天。			

脈診：脈浮, 一點數。
望診： 1、**舌診：**淡黃濕。 2、**眼診：**
耳診：
診斷： 上焦仍有餘熱。
中藥處方： 1. 膠艾湯 8 乾薑 1　　２００粒 (月經不止時才服) 8X3三餐飯前服 2. 白虎湯４黃連１黃芩１黃柏１大黃１　　400粒 8X3三餐飯前服
解說： 1膠艾湯 乾薑 → 月經惡漏不止。 2白虎湯 四黃 → 瀉上焦餘熱。 3 此人身上聚集有很多陳舊的奶水。 4 此人先前就是無時無刻都覺得很熱，倪師予以大劑白虎湯，石膏最高用至一斤仍覺得很熱，之後倪師依熱極生寒之理改予生附子，此人服後就覺得身體冷下來了。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**
ED	男	63歲，胖	2008/08/22
來診原因：左小腿肚抽筋，半夜嚴重，近來體檢血糖高些，體重少了50磅以上。之前足跟痛好了，右膝也好了，但覺得皮膚薄，易破裂，登山時又撞傷，現在右膝有傷口，夜間頻尿2次。			
問診： 飯後胃痛 有時會喉中自動封閉，經等段時間才自己打開 大便每天一次			
脈診：			
診斷： 真寒假熱			
針灸處方： 右：膝五針、築賓			
中藥處方： 1炮附子2 半夏2 梔子2 生地2 天花1 烏藥2 細辛1　400粒 10x2 早晚飯前服 2調胃承氣湯 200粒 8x2 午餐前及睡前服			
解說： 1築賓→消炎收傷口 2炮附子、半夏、梔子→利膈湯，治療喉嚨、食道之間的不利 3生地、天花→生津			

4烏藥、細辛→溫下焦，治頻尿 5調胃承氣湯→胃下方有東西堵住
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：？			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
FN	女	約50歲，中等	2008/08/07
來診原因： 四週以來皮膚過敏，夜間尤差，一靠著椅子或臥床即癢。			
問診：			
脈診：脈緩有力			
望診： 1、舌診：黃乾 2、眼診 ：			
耳診：			
診斷：非皮膚病，只是汗未發透，遇熱即癢。			
針灸處方：			
中藥處方： 麻黃加朮湯　　200粉 8x3			
解說：1.服後會出微汗然後皮癢即去 2.麻杏苡甘湯是用於有皮膚病(例如癬瘡等)的皮膚癢；麻黃加朮湯是用於外表看不出有啥皮膚病的皮膚癢。			
備註：			

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/07			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
FN	女	約50歲，中等	2008/08/14
來診原因： 五週以來皮膚過敏，夜間尤差，一靠著椅子或臥床即癢。初診後仍癢，因汗水仍無法透發			
問診：			
脈診：			
望診： 1、舌診： 2、眼診 :			
耳診：			
診斷：表受風邪，汗未出盡。			
針灸處方：　皮癢五針：血海、三陰交、築賓、曲池、合谷。			
中藥處方： 桂枝三錢 白芍三錢 麻黃三錢 杏仁三錢 薏苡仁四錢 生薑三片 大棗十枚 炙甘草三錢 連翹三錢 銀花二錢 荊芥三錢			
解說： 沿用麻杏薏甘湯，加桂枝湯固脾胃以堅固汗水之源，並加連翹、銀花、荊芥等發表。			
備註： 須翌日再針			

倪醫師病案紀錄			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
FR	M	約六十歲，中等高身壯	2008/08/29
來診原因：			

第一天撞車, 胸受損, 很痛 (現無痛了)
第二天又去看牙醫, 注射 Novocaine (麻醉劑)
第三天又正好是FAA檢查身體, 發現心律不整.

問診：

1. 睡眠不好, 因兩三次小便
2. 大便每日行
3. 小便深褐色
4. 口渴有 喜冷飲
5. 胃口好
6. 雙足冷

脈診：
左手脈時一止, 右手脈還好

望診
舌診：黃濕

診斷：有一點心律不整

中藥處方：
1) 炙甘草 五錢 桂枝五錢 生薑兩片 大棗十枚 熟地兩錢 黨參三錢 麻仁二錢 阿膠三錢 (分三包) 細辛二錢 烏藥五錢 炮附子三錢 黃連二錢 黃芩二錢
三付 九碗煮成三碗 早晚飯前吃
2) 服完湯藥之後, 因工作之故, 可服囊劑, 共400 caps, 每日三次 , 每次八粒, 飯前服用.

解說：
病家是航空公司機長, 每年須通過FAA體檢

倪醫師病案紀錄 初診日期：2008/08/15

姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
FR	男	54岁 中等	2008/08/15

來診原因：
摄护腺结石，造成肾痛（双腰肾有压力感）。高血压145/80mmHg。腰痛。
鼻炎仍有一点，造成左耳如发炎，右耳鸣如鼓声

問診：
睡眠：不易入眠
大便：每日行
胃口：好

口渴：有 双足：冷 腰痛：痛如带状横于腰骶部（带脉） 腰痛沿双腿后侧向下至膝国部（足太阳膀胱经）
脈診：脉洪有力
望診： 1、**舌診：**黄厚湿 2、**眼診**：
特殊診斷：
耳診：
診斷：上焦太热、湿
針灸處方： **双迎香**→鼻炎（针后用喷鼻药） **双腿肾结石点**→治疗摄护腺结石 **双足临泣、委中、阴谷**→带脉、膀胱经腰痛
中藥處方： 刷牙粉一罐 滑石 六钱　猪苓 三钱　茯苓 五钱　泽泻 五钱　阿胶三钱（分三包烊尽） 辛夷 三钱　菖蒲 四钱　苍术 五钱　黄连 二钱　黄芩 三钱 白芍 五钱　桂枝 五钱 服时加生蛋黄一只　　伍付 9→3碗 早晚餐前服
解說： 滑石 猪苓 茯苓 泽泻 阿胶 → 利水泻石 辛夷 菖蒲 苍术 → 清上焦湿热、通鼻窍 黄连 黄芩 白芍 桂枝 服时加生蛋黄一只 → 补心血不足，定神安眠
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**

GT	女	80歲，中等	2008/8/5

來診原因：
肺癌。上次因雙腳背不適，已治好。今次是腳外踝一帶麻腫。

問診：
1.胃口：好。
2.口渴：渴，喜室溫飲。
3.小便：淡黃。
4.睡眠：2am-7am。
5.痰：多而黃濁。
6.身體寒熱：深夜時覺熱。

脈診：洪大有力，一息六至。夏逢夏脈

望診：
1、舌診：紅淡乾
2、眼診：

特殊診斷：

耳診：

診斷：

針灸處方：

中藥處方：
炮附子五錢，白芍一兩，炙甘草五錢，葦莖四錢，丹皮三錢，桃仁三錢，
冬瓜仁三錢，黃耆五錢，牛膝三錢。
十付

解說：
凡肺癌必熱，因有如汽車之水箱壞了，喪失散熱功能。肺癌以稀白痰為危險，今吐黃濁痰，情況尚好。吐白痰時用大劑桔梗甘草湯，黃濁痰則用千金葦莖湯意，凡無表證之黃濁痰，均以葦莖去之。如肺痛兼下痢，用紫參湯，紫參入血分以攻堅。病婦人八十歲，仍得肺癌，可證停經後仍有奶水，必須注意。另老人脈洪大有力，本為反脈，但正值炎夏，無虞。腳外踝腫麻，施針處理。

備註：
針下雙足丘墟、申脈、俠溪。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/8/5			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
GT	女	80歲，中等	2008/8/19

來診原因：

肺癌複診，上次複診有腳患，今已除。但因氣喘及血壓升至160故擔心來診。本週起不能平躺睡覺，且自述減了四磅。

問診：

1.胃口：很好。
2.口渴：渴，喜冷飲。
3.小便：淡黃，流量好。
4.大便：每日行。
5.睡眠：因夜尿三、四次故斷續醒來，但醒後能再睡。
6.身體寒熱：日間無寒熱，夜裡覺全身熱，但腳仍冷。
7.體力：很好。
8.雙足：冷。

脈診：浮大，關大於寸。

望診：

1、舌診：淡黃紅
2、眼診 ： 肺區黃為有痰，有白點為肺癌。

診斷： 肺中陰實仍在

中藥處方：

沿用前方：
炮附子五錢，白芍一兩，炙甘草五錢，葦莖四錢，丹皮三錢，桃仁三錢，
冬瓜仁三錢，黃蓍五錢，牛膝三錢。
三付

解說：

病人所患肺癌，但四肢黃而瘦，是肺結核的表徵，在中醫觀念，肺結核是癆症之一種，治法當依癆症。此外，肺脈就是浮脈，常人脈象是寸比關浮，關比尺浮，一直往下沉的，這才符合陰陽。但病人則是關脈比寸脈浮大，是陰陽相反的證明，再加查脈之有無附骨，並加眼診，可斷其陰實未去，故續用前方。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2007/02/21			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
HJ	F	53歲，中等身材	2008/08/05

來診原因：1.初診乃因關節痛服類固醇9年，導致腎衰竭，等待腎臟移植，同時心臟有50% 血管阻塞。
2.本次就診乃因服西藥（sensipar 副甲狀腺藥物，師云：心臟有問題時甲狀腺也會有問題），造成隔日必嘔吐、噁心，人很焦慮，落髮重，

睡不好，走路不平衡，足踝有舊傷。
問診：（1）無胸痛。 （2）雙足熱。（初診時雙足冰冷） （3）關節腫已痊癒。 （4）大便每日5-6次。 （5）有尿意，但解之只有幾滴。 （6）胃口不好，一直感覺噁心。 (7)無頭暈→腎衰竭患者會出現頭暈噁心，故詢問之 （8）口渴，喜冷飲。 （9）睡前身熱，需吹電扇。 （10）運動無汗出。
脈診：脈數有力。
望診： **1、舌診：**舌體大，舌面多小空洞，舌中直裂紋中空。（心臟受損之象） **2、眼診**：（1）瞳孔無反應、體積小、形狀略異常→腎陽已失。 （2）內眥扁而淡紅夾有黃白濁斑→心臟肥大、貧血且兼有痰飲。（正常內眥成圓形色鮮紅）
特殊診斷：
診斷：腎陽已失，水泛中焦故嘔吐。
中藥處方：旋覆花三錢 代赭石三錢 乾薑二錢 生薑二片 澤瀉五錢 桂枝五錢 半夏三錢 茯苓三錢 丹皮三錢 白芍五錢 牛膝三錢 川芎三錢 桃仁三錢 十付 九碗水煮成三碗，每天早晚飯前各一碗

解說：1.病患為中年白人婦女，因未能按時回診，又持續服用西藥，導致身體狀況越來越差。本日回診時精神略萎靡，說話低聲略無力，經常重複類似話語，自述不畏懼病痛但其實十分焦慮。師對本病患不愛性命之行為亦頗有微詞，同時認為病情相當棘手。
2.病患腹大，主要是因為肺中水氣要進入腎中，但無法下降進入，堵在中焦所致。 3.處方以旋覆花、代赭石降逆止嘔，利用金石類藥物重墜以鎮逆。乾薑溫中止嘔，生薑（配半夏）散水氣。澤瀉、半夏、茯苓利水。丹皮、白芍、牛膝、川芎、桃仁活血化瘀。 4.此人有心血管疾病為何仍用白芍？師曰：因此人足踝受傷過故欲用白芍活血化瘀，而此人無胸滿故可用白芍。
備註：

倪醫師病案紀錄 初診日期：2008/08/27			
姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**
HJ	男	30歲	2008/08/27

來診原因：

從高中到現在早晨起床精神都極差，如同沒睡般，白日極度想睡，近一年來連晚間也失眠。來診時已是白日極度想睡，而晚上完全不能睡的狀態。問診時表現焦慮，難以集中，有點語無倫次。已吃了好一陣子的安眠藥和抗焦慮藥。但白天仍然極度想睡，甚至開車開到一半也會睡著。

問診：

（1）胃口：不好。
（2）大便：二天到四天一次(服HT68號養肝丸後較好)。
（3）睡眠：晚間不能眠，白日極想睡。
（4）手足：皆冷。
（5）頭痛：已無。
（6）寒熱：身無寒熱。
（7）口渴：不口渴，會忘記喝水。
（8）飲食：時常一天只吃一餐，會忘記吃飯。
（9）出汗：易出汗。
（10）其他：表現焦慮。

脈診：脈浮數中空

望診：白紅乾

耳診：無

診斷：裏寒實，造成陽不入陰。

針灸處方：無

中藥處方：

生附子二錢、乾薑二錢、炙甘草三錢

白术三錢、茯苓三錢、澤瀉五錢、桂枝三錢
炮附子三錢、細辛二錢、大黃三錢
龍骨三錢、牡蠣五錢、半夏三錢
五付，九碗煮成三碗，早晚餐前各一碗。

解說：

白天想睡是陰外出，晚上睡不著是陽外出，這與正常人剛好相反，師曰此是裏寒實，陽不能入陰導致晚上不能睡，白天反而陰氣外出，故欲寐。

四逆湯除裏寒，大黃附子細辛湯除下焦寒實。龍骨牡蠣鎮定心神。

(請問老師：何以方中用五苓散架構卻去豬苓？方中半夏未知何義？是取靈樞中半夏秫米湯中用半夏之意嗎？倪師答：一般病人小便已多即去豬苓不用；沒錯，此乃取半夏秫米湯治無胃口的失眠。)

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/03/05

姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
HM	女	約50歲，　微胖	2008/08/13

來診原因：

腹膜癌開刀轉移至肝，上週抽11磅腹水，現在肝區痛，腹水又回

問診：

睡不好，每一、二小時就醒
胃口餓，無法吃很多(因胃會脹)
口渴有，喜溫飲
大便每日行，量不多
小便淡黃，有時尿不出來感，量不多
覺身體冷，雙足不冷
有一點腿腫
體力較差

脈診：洪數有力附骨

望診：氣色黑

1、**舌診：**淡白紅

2、**眼診**：

特殊診斷：

耳診：

診斷：　裡陰實之症

針灸處方：　水分、關元

雙：三皇穴、水道、足三里、章門、期門、腎俞、京門、肝俞、脾俞

中藥處方：　補氣治濕湯+生硫磺

人參四錢　白朮六錢　蒼朮五錢　茯苓五錢　陳皮五錢　麥冬五錢　當歸五錢
木通四錢　黃芩三錢　厚朴三錢　升麻三錢　生硫磺二錢(另包)
三付　六碗水煮成兩碗　早晚飯前各一碗

解說：

1腎俞、京門→俞募治療法 2生硫磺→利水
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/03/05			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
HM	女	50歲，中等	2008/08/20

來診原因：
昨天抽出腹水4700cc，回診。

問診：
抽腹水之後，小便出500cc，大便出成形
口渴有，喝室溫水
身體內是熱的，全身熱
雙足熱
胃口好，會餓
呼吸短氣，一點咳嗽

脈診：稍洪數，一息六至

望診：
1、舌診：黃厚乾
2、眼診 :

特殊診斷：

耳診：

診斷： 仍以健脾為主要方，利濕

針灸處方： 因昨天抽腹水，身體虛，不下針

中藥處方：
1補氣治濕湯+生硫磺三錢(另包)　十二付 六碗水煮成兩碗 早晚飯前各一碗
2胃苓湯　400粉　午餐前、睡前各二茶匙

解說： 此人因有開刀、化療過，師認為因身體結構被破壞而會讓中醫下手時產生盲點，故之前有說若腹水嚴重可去抽水，但一定要完全用中藥調理

備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/04/25			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
HN	F	54歲，身材中等較瘦	2008/08/15

來診原因：
1990年乳癌開刀，並作八次化療（化療後即停經），之後服藥（Tomoxifen）五年。到2003年，又再次發現乳癌，並轉移至骨頭產生骨癌。
經倪師及大師姐治療後略有改善，也停服西藥，西醫檢查癌細胞未再增生，但亦未減少。今日持續回診。目前仍有服西藥（Keppra、SAHA）。

問診： 睡眠時好時壞，不定時醒。 髖關節部位有疼痛感。 服SAHA後雙肋痛，不服時則不痛。 雙足時冷，偶爾熱。 體力不好（倪師認為是服SAHA引起）。 睡時身溫正常。 口渴尚好。 胃口好。 手涼。 乳房無傷口或流血。 夜晚平躺時心跳快。
脈診：緩有力，尺脈近無（裡寒）。
望診 **舌診：**淡黃紅濕。
診斷：裡寒仍有。
中藥處方： 同2008/04/25處方，加生附子三錢（另包）。五帖，九碗煮成三碗，早晚餐前各服一碗。

解說：

以下為初診（2008/04/25）病歷與處方：

問診：（1）睡不好時又好，無定時醒。

（2）每日大便。

（3）胃口好，味覺好。

（4）體力不好。

（5）小便正常。

（6）雙足冰。

（7）晚上時身熱。

（8）時關節不定點痛。

（9）口渴尚好，半夜口渴多。

（10）汗出不多。

（11）手涼，額溫。

脈診：雙手附骨脈。 舌診：淡黃紅

眼診：心陽不足、陰也不足，右腎陽失、左腎尚好，肝區肺區陰實。

診斷：陰寒證無疑。

處方：黃連二錢 黃芩三錢 白芍五錢 阿膠三錢（分三包烊盡）

炮附子四錢 細辛二錢 柴胡三錢 玉金五錢 龍膽草三錢

牡蠣六錢 瓦楞子五錢 桂枝五錢 炙甘草三錢

補骨脂三錢 澤瀉五錢 生地三錢 茜草三錢 當歸二錢

白朮五錢 茯苓五錢 五帖，九碗煮成三碗，早晚餐前各服一碗。

說明：黃連阿膠湯補心血治失眠，炮附細辛溫裡寒補腎陽、炮附味鹹尚可軟堅，柴胡黃芩玉金龍膽草配合茜草當歸可清肝解毒、補血兼去陰實，桂枝炙甘草強心陽，補骨脂澤瀉生地補腎，白朮茯苓固中焦，牡蠣、瓦楞子合用攻堅可治療乳癌。今日因病患仍有裡寒，故加生附子。

附上西藥相關背景供參考：2008/01/19歐盟執委會核准Levetiracetam(marketed as Keppra)用於12歲以上原發性全盤性強直陣攣發作之難治體質型泛發性癲癇輔助治療，是治療腦神經病變導致抽搐的癲癇藥，但可能需要承受癲癇藥帶來的嚴重抑鬱、躁狂、精神病、甚至自殺的藥物副作用。同時也可治療罹患實質器官癌症之成人病患因化療引起之貧血。但美國FDA在2008年1月也發出明確警告，長時間使用某些抗癲癇葯物治療癲癇大發作、偏頭痛、雙極性精神病和其它症狀，有可能會引致服葯者自殺，這是美國一些醫療機構在追蹤了多名自殺者的病歷後得出的結論。

histone deacetylase inhibitor組蛋白去乙酰化酶抑制劑(HDACIs)，包括丙戊酸和SAHA，而SAHA是默克藥廠目前處於二期臨床試驗階段治療癌症的化合物，其機轉是透過一種不同於化學治療的機制抑制了癌細胞生長，因此號稱有希望阻斷抑制卵巢癌和其他癌症的生長，但沒有化學治療那樣的毒性。參 http://www.oncolink.upenn.edu/resources/article.cfm?c=3&s=8&ss=23&Year=2005&Month=01&id=11474

倪醫師病案紀錄 初診日期：2008/04/25

姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
HN	F	57歲，身材中等較瘦	2008/08/22

來診原因：

1990年乳癌開刀，並作八次化療（化療後即停經），之後服藥（Tomoxifen）五年。到2003年，又再次發現乳癌，並轉移至骨頭產生骨癌。

經倪師及大師姐治療後略有改善，也停服西藥，西醫檢查癌細胞未再增生，但亦未減少。今日持續回診。目前仍有服西藥（Keppra、SAHA）。

問診：服前方後

睡眠尚好，但睡不深，時又無法入眠。

雙足溫度上升許多，有時很熱，多數時是熱的，尤其晚上很熱；但身無熱。

胃口好，吃很多，味覺好。

環跳仍痛。

體力時好時壞（倪師認為是服SAHA引起）。

大便很好。

小便淡黃。

喜涼飲

午後無身熱。

脈診：沈稍數、有力。

望診

舌診：舌中間部位苔淡黃濕，兩側較少苔，質紅。

特殊診斷：眼診

右瞳孔對光較無反應→右腎陽不足。

雙眼肝區較鬆散、不緊實感→肝區受損。

雙內眥色較淡→心陽不足。

白睛上有1-2條血絲→師云白睛上見3條血絲以上者會發作癲癇。

診斷：病人進步許多，陽脈大於陰脈，陰陽協調；但脈仍沈細→裡寒仍有。

中藥處方：

同2008/04/25處方，加生附子二錢（另包）。七帖，九碗煮成三碗，早晚餐前各服一碗。

HT-34六兩，早晚餐後各服30粒。

解說：
病患有明顯改善，但病症尚未痊癒，且診斷後病因病機仍相同，故效不更方，方義同前。 　　而病患裡寒證有減少，所以將生附子減量。 因病患抱怨會掉髮，故兼服HT-34補天丸。 3.同時倪師要求病患停服SAHA。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
HY	F	45歲，中等身材	2008/08/14

來診原因：
後肩痛，後腰痛在帶脈。
雙乳有硬塊，兩個月前發現。

問診：
睡不好，每日2：15am必醒，可再入睡。
胃口很好。
大便三天一行。
月經很準時。
小便淡黃。
肚子肥大，有時排氣。
雙足冷，睡時身冷。
口渴無。
經常身體冷。
經前右乳有一硬塊會痛（位於足少陰經上）。再約兩週後月經將至。

脈診：脈緩有力。

望診
舌診：淡黃乾。

診斷：

針灸處方：
梁丘、上巨虛、解谿、太衝、後谿、申脈、足臨泣、外關（以上雙側），左然谷。
梁丘為胃經郄穴，可治療經脈上不論虛實的痛症。
上巨虛：治膀上氣實之病，令其虛之。
解谿：同時打開經脈（只限胃經嗎？）中阻塞之氣，猶如河川疏浚使之流暢。
太衝：再引大水由高處往下衝，加速水道（經脈）之順暢。
後谿配申脈：針對項肩強痛的治療。
足臨泣配外關：治療腰痛。外關尚可治療三焦、陽維之病。
然谷：腎經，因為要導引水出（腰痛因濕重引起），水在深層，故要深刺至骨邊。

中藥處方：
柴胡三錢　玉金五錢　黃芩三錢　龍膽草三錢
炮附子四錢　桂枝三錢　白芍三錢　炙甘草三錢
當歸二錢　木通三錢　細辛二錢　大黃二錢　牡蠣一兩
五帖，九碗煮成三碗，早晚餐前各服一碗

解說：
病患原先就診原因是肩痛與腰痛，但後來又提及乳房有硬塊，倪師認為肩痛與腰痛以針刺治療即可痊癒，乳房硬塊則需服藥治療。 病患月經週期雖然正常，但經前乳脹時會有一小區域特別痛，此即奶水堆積之患部。本次處方先以柴胡、玉金、黃芩、龍膽草針對睡不好，每日2：15am必醒的症狀治療；當歸四逆湯加大黃治療雙足冷、睡時身冷及便秘；牡蠣軟堅。同時病人雖有寒證，但因未到用生附子的程度，故用炮附子，且炮附味鹹還能軟堅。 至於用四物湯加炒麥芽治療乳房硬塊的方法，則在月經來之前再開始服，屆時利用奶水下行的自然生理變化時機用藥，效果更好。
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
HY	F	45歲，中等身材矮胖	2008/8/21

來診原因：
後肩痛，後腰痛在帶脈。
雙乳有硬塊，兩個月前發現。
回診持續治療。

問診：
服藥後乳房腫塊略縮小，月經準時來，今天第一天。經來左乳變小，右乳仍大。
睡眠好轉，2：15am不再醒了。
大便一日一次。
小便淡黃。
雙足冷，睡時身仍冷。
無口渴。

脈診：右脈大於左脈。(女子以血為主，正常脈應為左略大於右，目前脈象應是因為月經來潮，經血排出之緣故。)

望診
舌診：黃濕厚。

診斷：

中藥處方：
HT-2 六兩。 每次40顆，早晚餐飯後服。
同2008/08/14處方，因病人要旅行一週，改為粉劑膠囊。每次10顆，午餐前及睡前服。

解說：
病患因部分症狀有改善、部分症狀仍持續，故守方再服。
因月經至，故加服HT-2退奶丸（成分不明，推測可能為四物湯加炒麥芽、牡蠣…等藥？)，並以其為主要處方（劑量較重)，利用月經期間奶水下行的自然生理變化時機加強清除奶水的效果。

備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
KC	女	50　中等	2008/08/08

來診原因：痔瘡，有出血，外痔初診後已縮小，內痔很大，時下垂出。排出血絲血水，為塊狀，如果凍，時滴漏出。

問診：
睡得好，但痔瘡會滴漏，需起來換墊子。
小便無力，呈深黃色
近一個月來胃口不好

口渴尚好
雙足冷
睡時身冷，時寒慄
大便色黑
小便深黃
喜飲溫水

脈診：脈沉細附骨(師曰: 直腸癌)

望診：
1、舌診：淡黃濕
2、眼診 ：

診斷： 裡寒，寒熱病結。肛門有實症，胃時痛為胃寒。

針灸處方： 大杼、腎俞、委中、陰谷

中藥處方： 吳茱萸三錢，乾薑兩錢，生附子二錢(另包)，炮附子五錢，黃柏三錢，黃芩三錢，槐花三錢，赤豆五錢，當歸三錢，灶心土五錢(另包)，白朮三錢，熟地三錢，阿膠三錢(分三包，烊盡)，升麻四錢。伍付，九碗煮三碗，早晚餐前服。

解說：
師曰:寒熱並結為厥陰症。
胃寒用吳茱萸乾薑湯。
槐花，赤豆治痔瘡。
炮附子收表（師曰：凡要”收”，皆可用炮附子。）
痔瘡下垂嚴重，用升麻提中氣。
黃土湯治黑便。
病人寒慄，有裡寒，用生附子。
8.一般大 小便時有出血或色深都以黃柏來去熱，黃柏為下焦去熱要藥。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/8/13

姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
KS	女	38歲，中等	2008/8/13

來診原因：掉頭髮，黑斑，睡不好，咳嗽打噴嚏有尿液滲出，頭暈，便秘，乾眼，肚子大，頸部有突出物，經期來若走路較多，會酸痛影響睡眠，痔瘡。

問診：
睡眠：每天到3:00都醒來。
開車或走路一小時會暈。
大便：便秘三天一次。
小便淡黃，有時深黃。
排氣有。
看電腦螢幕久會眼乾。
如喝多水或喝西瓜汁則手指腫。
月經正常28天，每次約五天。
雙足熱。

脈診：稍浮緩有力。
望診： **舌診：**淡白乾。
診斷： 水停中焦。
中藥處方： 桂枝五錢　白朮四錢　茯苓五錢　豬苓三錢　澤瀉五錢　側柏葉五錢　當歸三錢　茜草五錢　川芎三錢　白芍五錢　丹皮三錢　厚朴二錢　大黃三錢　枳實二錢　柴胡三錢　玉金三錢　酸棗仁三錢　半夏三錢　南星三錢 200 克粉　　三餐前三茶匙　　先用粉，不行再用湯劑
解說： 桂枝五錢　白朮四錢　茯苓五錢　豬苓三錢　澤瀉五錢→五苓散，去中焦水。 側柏葉五錢　當歸三錢→生髮。 茜草五錢　川芎三錢　丹皮三錢→去子宮瘀血治黑斑。 厚朴二錢　大黃三錢　枳實二錢→小承氣湯治便秘。 柴胡三錢　玉金三錢　酸棗仁三錢→治肺先治肝。 半夏三錢　南星三錢→去肺中的津液。 女人臉上有黑斑，多為子宮有瘀血。將瘀血清出即可。 病人陳述，一運動就頭暈，表示中病。病人應多運動。 皮膚上的突出物為疣，可以電射移除，或是以燈心草燒掉。 多吃甜食容易掉頭髮，師囑病人喝開水或是茶，不要吃甜食和其他飲料。 病人的脈為浮表示有表症，又為弦表示有水，用五苓散。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：２００８／０４／１７			
姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**
LA	女	３０歲，細小	2008/08/06
來診原因： 月經曾不規則，服5/19方後已規則。三月來已正常，今來覆診，並欲再產子。			
問診： 1.月事如何：近三月都每月一行。下次月經將於下週來。 2.怕冷嗎：較不怕冷。 3.睡眠：睡不好。(因5/19方有麻黃)→此女月經以正常代表心臟有好轉但他睡眠不好故知心臟仍還不是很好 4.白天還想睡嗎：減少了。 5.運動有汗嗎：有。 6.還有盜汗嗎：已減少。 7.大便：每日行。 8.小便：淡黃色。 9.口渴嗎：有一點。 10.喜熱飲冷飲：喜室溫。			

脈診：脈緩、細小

望診： 手掌一直都乾，冬季則脫皮，按三陰交則無壓痛
1、**舌診：**淡紅舌，有齒痕
2、**眼診** ：肝區圈紋且有破洞

耳診：

診斷：裡寒、血虛

針灸處方：

中藥處方：
桂枝三錢 白芍三錢 炙甘草二錢 大棗十枚 當歸三錢 木通二錢
細辛二錢 熟地二錢 川芎三錢 柴胡三錢 玉金五錢 酸棗仁三錢
丹皮三錢 麥冬三錢
20帖 9 碗水煮成3碗

解說：用當歸四逆湯補虛去寒，因他大便每天有，故木通輕用。因下焦有實，心熱逆行到手致乾 。因多用陽藥，故必生男。如要產雙胞胎，須用風水改建廚房於東與東南之間。

備註：２０付

‘

倪醫師病案紀錄	初診日期：2008/08/14		
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LA	男	40	2008/08/14
來診原因:病人自述心臟早搏，視神經凹陷，手足冷，有汗，失眠，心悸，頻尿，			

早上起來背後第五椎有麻感，睡覺時必須左躺，右躺則心跳快不能眠。服少許安眠藥幫助睡眠。有氣喘病史，偶噴氣管擴張劑。
問診：1. 運動時有汗, 2. 近來腳較冷, 3. 壓力大時心動悸,4. 每日有大便, 5. 尿頻, 每飲水則小便多, 6. 胃口好, 7. 口渴尚好, 8. 不會盜汗, 9. 不怕風吹 10.晚上身無寒熱 11.雙手足冷
脈診：脈浮弦數有力
望診： 1、舌診：白厚乾 2、眼診 ：
耳診：
診斷： 水氣凌心
針灸處方：
中藥處方： 桂枝五錢，炙甘草五錢，龍骨五錢，牡蠣一兩，烏藥五錢，細辛二錢，茯苓三錢，澤瀉三錢，先三帖，九碗煮三碗，早晚飯前服
解說：病人心火不足，小腸火不能有效氣化水分，造成冷水積聚。水克火，水氣凌心造成心動悸。用桂枝甘草湯強心火。龍骨牡蠣湯使陽固守，治頻尿。烏藥治頻尿，細辛可引心火下行入小腸。用茯苓澤瀉利中下焦之水。有心動悸時不要用白芍，因白芍加強靜脈血回流，加重心臟之負擔。患者體內沒水液停聚時澤瀉用三錢即可，有水液停聚時用五錢。
備註：

倪醫師病案紀錄	初診日期：		
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LE	女	65岁 瘦小	2008/08/22
來診原因：咳嗽坐不得卧复诊。（肺癌末期） 咳嗽仍多，但晚上三点后可平躺了，仍有胁痛。 喉中偶然痒，会引起咳。			
問診： 睡眠：尚好 寒热：时冷时热，无汗 胃口：好 口渴：有，喜冷饮 体力：仍差 昨日服藥後略下利			
脈診：脉仍弦细			

望診：

1、舌診：白红干

2、眼診 ：

診斷：肺中有水气，无痰咳出

中藥處方：

桔梗 一两 炙甘草 五钱 麻黄 三钱 射干 三钱 紫菀 三钱 冬花 二钱

半夏 三钱 麦冬 三钱 五味子 二钱 干姜 二钱 生姜 二片 大枣 十枚
党参 三钱 拾付 9-3碗 早晚餐前服。

仍有三付8/12寄出的药未喝，先服今开的药

解說：

1、该病人一年前因肺癌末期来诊

2、昨因咳嗽一直不好，已经从肺中抽过一次痰水，仍咳嗽但坐不得卧而再诊，予半夏甘遂大枣汤，急泻胸肋之积水。

3、今再诊，患者已可平躺，但仍咳嗽，时喉痒，知其胸肋积水已去，然肺中仍有水气。
重用 桔梗 一两 炙甘草 五钱 托排肺中积痰，利肺气
予射干麻黄汤去细辛，以去肺中水气。（问：为何去细辛？是否因患者口渴喜冷饮，中有热故?倪師答：對）

4、干姜 生姜 大枣 党参，增补肠胃津液

倪醫師病案紀錄 初診日期：2008/04/01

姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LJ	女	16歲左右，略矮，瘦	2008/08/01

來診原因：服4/25方後仍無汗出，手足時熱，不是一直持續熱。

問診：（1）大便秘，隔日一行。
（2）小便黃。
（3）無排氣。
（4）無法睡。
（5）月經正常。
（6）口渴重，喜冷飲。
（7）無關節痛。
（8）胃口好。

脈診：浮數。

望診
舌診：白淡紅。

耳診：無。

診斷：表實裡熱（大青龍湯證）
針灸處方：無。
中藥處方：麻黃3 石膏1 兩 杏仁3 炙甘草3 桂枝3 生薑2片 大棗10枚 厚朴2 枳實2 大黃2 芒硝1（分兩包沖服） 單位：錢，用大火6碗煮成2碗 ×5帖 ◎師云：本處方服後若覺心跳太快不適，每服減量。同時服藥後約半小時若出汗後，嚴禁吹風（冷氣）及入冷水中。
解說： 病患為一年輕越南女子，先前就診原因即是手掌色鮮紅而熱，手臂及小腿皮膚粗糙、觸之有顆粒狀感，毛細孔大而可見。前診師以下列處方治之： 麻黃3杏仁3薏仁5 炙甘草3 桂枝4 白芍5 生薑2片 大棗10枚 柏子仁3 淮山3 黃芩3 山茱萸3 病患主訴服藥後仍無汗出，心跳也僅稍微加快，師認為此乃藥物劑量不足之故。由於汗不出身熱不解，病患也曾依師之囑以孫思邈冷水浴生大熱之法沐浴，仍無汗出。故本次回診時師重新加以處方。
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/04/1			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LJ	F	16歲，略矮，中等身材	2008/08/06
來診原因：服藥之後，腋下及腘中出汗。且自覺身體痛、肌肉酸痛。			
問診：（1）大便已正常，一日2次。 （2）服藥之後沒有心悸。 （3）已無口渴。			
脈診：浮數。			
望診 舌診：淡紅。			
耳診：無。			
診斷：有出一點汗，但不夠。（無心悸）			
針灸處方：無。			
中藥處方：麻黃四錢 石膏一兩 杏仁四錢 炙甘草三錢 桂枝三錢 生薑2二片 大棗十枚 厚朴二錢 枳實二錢 大黃二錢 芒硝一錢（分兩包沖服） ×5帖 以大火6碗煮成2碗，早晚餐前各服一碗			
解說： 病患服藥後諸症狀改善，手掌色雖仍較鮮紅，但熱感減輕，小腿皮膚毛細孔污垢黑點減少，變得較乾淨。 腋下及腘中因毛細孔較少，故汗出較明顯。至於身體其它部位乃因毛細數量較多，且津液聚於皮肉間尚未能順利發出，故仍較無汗且反而產生身體痛、肌肉酸痛的症狀。 3. 因此本診處方加重麻黃劑量，加上等量杏仁避免麻黃使用過量發汗傷及肺陰。			
備註：			

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/04/1			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LJ	F	16歲，略矮，中等身材	2008/08/13

來診原因：服藥之後仍無汗出，只有腋下及膝下出汗。

問診：（1）大便一日2-3次。
（2）服藥之後沒有心悸，無身熱。
（3）身體肌肉已不酸痛。
（4）手涼額熱。

脈診：浮數。

望診
舌診：紅。

診斷：仍有大青龍湯證。

中藥處方：麻黃五錢 石膏一兩 杏仁五錢 炙甘草三錢
桂枝四錢 生薑二片 大棗十枚　　×7帖
以大火6碗煮成2碗，早晚餐前各服一碗

解說：

病患服藥後仍無明顯汗出，手掌及足部膚色仍絳紅，倪師認為此乃皮下鬱熱仍在；而小腿皮膚毛細孔雖仍目視可得，但已不見污垢黑點，原有身體痛、肌肉酸痛的症狀也已痊癒。

因此本診持續處方加重麻黃劑量，同樣加上等量杏仁避免傷及肺陰，桂枝劑量亦加重以助發汗

排便已順暢，故將前方中大承氣湯去除。

備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/04/1			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LJ	F	16歲，略矮，中等身材	2008/08/22
來診原因：服藥之後仍無汗出。			
問診： （1）服藥之後仍沒有心悸。 （2）但不易入眠。			
診斷：可用消導劑從下治。			
中藥處方：五苓散 400 caps，三餐前每服八粒。			
解說： 病患服藥後仍無明顯汗出，手掌及足部仍有熱感（本次就診膚色較不若前次絳紅），倪師認為病患已有不易入眠的症狀，此乃麻黃劑量較大、發陽所致。若再加大劑量發表，恐睡眠狀況會更差，經詢問病患，病患不願睡眠差，故倪師改變引邪外出之途徑，以五苓散將表濕從皮下排出。			
備註：			

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LJ	女	37 胖	2008/08/05
來診原因：兩個月前左乳頭正下發現硬塊			
問診： 月經準時，提前一天左右(師曰:人胖月經易提前)，月經前乳脹腫塊會痛，月經來後痛去 晚上睡時身熱，約下午七八點時身熱煩(師曰:陽不入陰) 可通宵睡 雙足熱 口渴，欲飲冰水 胃口好 白天易累 大便正常 左肋下方刺痛，一天痛一天不痛，不持續痛。 額涼手溫			
脈診：脈緩沉			
望診： 1、舌診：淡白紅 2、眼診 ：			
耳診：			

診斷： 上焦濕熱重，胃火過盛
針灸處方：
中藥處方： 石膏四兩，知母五錢，生地兩錢，天花三錢，麥冬三錢，旋覆花三錢，代赭石三錢，柴胡三錢，半夏三錢，茜草三錢，炒麥芽五錢，牡蠣一兩，川芎三錢，白芍三錢，當歸兩錢。共十五付，九碗煮成三碗，早晚餐前服。 HT-2 退奶丸三兩，早晚餐後各三十粒，月經來時服。
解說： 陽明經熱白虎湯證，用石膏，知母。 旋覆花，代赭石，柴胡，半夏，茜草治左肋下方痛(初診時為胰臟炎)。 牡蠣鹹能軟堅，治乳下硬塊。 四物湯加麥芽消乳房腫塊。 天花粉，麥冬生津止渴。
備註：

倪醫師病案紀錄	初診日期：2008/08/29		
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LJ	F	47歲 160cm 50kg	2008/08/29
來診原因： 今年一月發現乳癌，3/20做過切片。有吃鈣片（←快停掉），沒吃乳製品。 停經前４、５年有吃痛經止痛藥。			
問診： １右乳時刺痛，無定處（切片後嚴重許多），多在心包經上 ２月經停了有兩年（2006開始無經） ３雙足冷 ４睡不好 ５大便每日行，未盡感 ６小便淡白 ７口渴無，逼自己喝水→裡寒 ８自覺體內冷 ９不易出汗，胃口好。			
脈診：沉小，細，無力→秋得冬脈很好治			
望診： 1、舌診：淡紅黃（好治） 2、眼診 :			
特殊診斷：			
耳診：			
診斷： 裡寒之人，心陽不足			

中藥處方： 生附子二錢（另包）　乾薑二錢　炙甘草五錢　桂枝四錢　白芍四錢　當歸二錢　細辛二錢　木通三錢　防己五錢　牡蠣一兩　瓦楞子五錢　川芎三錢　黃耆五錢 拾付　九碗煮三碗水　早晚飯前
解說： １手足冰冷加重桂枝白芍到四錢，無積水可以加重炙甘草到五錢。 ２大便不通加重木通到三錢，下焦寒用細辛，防己入三焦淋巴。 ３左血右氣，因在右邊所以加黃耆補氣行氣，若在左邊則加重活血化瘀的藥，如茜草、牛膝、三七、續斷。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	**性別**	**年齡及體型**	**來診日期**
LL	女	～55，中等	2008/08/01
來診原因： 失眠嚴重。兩頰褐斑點仍有（在胃經上），時時會癢。Blood test顯示肝功能不太好。			
問診： 1、**睡眠：**不好 2、**胃口：**時好時壞 3、**大便：**一天一次 4、**口渴：**口渴喜室溫飲 5、**其他：**胃酸逆流好了。體重降了一點點。Hot flashes基本沒了。			
脈診：心脈小，胃脈大→胃下垂之脈			
望診： 1、**舌診：**淡黃白			
診斷：裡熱仍有，經熱與腑熱皆有			
中藥處方： 石膏　五兩，知母　五錢，生甘草　三錢→白虎湯，去陽明經熱 柴胡　三錢，黃芩　三錢，龍膽草　三錢，鬱金　五錢，茵陳　三錢→清肝解毒 黃連　二錢，阿膠　三錢，白芍　五錢→黃連阿膠湯，補心血 連翹　三錢，銀花　二錢→質輕，走上走表，清皮表風熱 五付			

9→3碗，早晚餐前加生蛋黃一只溫服一碗 HT-85敷臉方　6兩 外敷，和蛋清混合
解說：1.心脈大者不易入眠 2.女性生殖器官有疾病或裝避孕器常會在臉上陽明經處出現斑點
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：２００８／０８／１３			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LL	女	約４０歲，正常	2008/08/13
來診原因： 咳嗽，自述已歷一週，用力咳會咳出黃痰，曾服千金葦莖湯，今已無痰，只餘咳嗽。			
問診： １.月事如何：有血塊，無經痛，但經期間排大便會痛，月事提前。 ２.睡眠：多夢，有時會醒。睡時身體覺冷。 ３.手足：手熱，足趾冷。 ４.大便：每日行，但不易出，有痔瘡感，屁多。眼看病人肚子過大。 ５.小便：中黃。 ６.口渴：口覺乾。 ７.喜熱飲冷飲：喜熱茶。 ８.嘔心脅痛：不嘔心，但吃飽後右脅會痛， 病人自述有時會腳腫。又因提行李拉傷，造成心痛徹背。			
脈診：稍數、有力			
望診： 1.舌診：黃 乾 2.眼診 ： 肝區圈紋，胰區好，腎區有反應 3.穴診：陽陵泉略有壓痛。雙三陰交壓痛			
耳診：右耳膽區略有壓痛。			
診斷：膽囊塞，肺中燥熱。			
中藥處方： 柴胡三錢　枳實三錢　黃芩三錢　炙甘草二錢　五倍子三錢　海金砂三錢 黃連二錢　白芍五錢　阿膠三錢(分三包烊盡)　葦莖三錢　冬瓜仁三錢 丹皮三錢　桃仁三錢　厚朴二錢　大黃三錢　槐花三錢　當歸二錢　赤小豆四			

錢　澤瀉五錢　　豬苓三錢　　茯苓四錢　　拾付
解說：因右脅非持續痛，故非膽石，但正在形成中，故用柴胡、枳實、五倍子、海金砂等攻其未病。阿膠用以防止攻石引致出血。肺中仍熱，會產生黃膠痰，跑到胸腔造成心痛徹背，加上舌乾口渴，故用芩連，並續用葦莖、冬瓜仁、桃仁等清肺熱，去黃稠痰。因多屁，排便不暢，用小承氣湯。有痔瘡感，用槐花、當歸赤小豆治其下焦血分濕熱。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2007/11/6			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LL	女	16歲，瘦	2008/08/11
來診原因： 初診時，顛癇非常嚴重，全身抽筋，雙腳內翻，神志不清，口水直流，服藜蘆甘草湯，現已改善許多。			
問診： 胃口仍不好 自五月中迄今，已無全身抽筋了 現在服藜蘆甘草湯，已不多痰出了 人可轉直立行走了，且意識清醒許多，抽筋也好許多，雙腿不再內屈			
脈診：			
望診： 1、舌診： 2、眼診 :			
特殊診斷：			
耳診：			
診斷：　筋急→肝，食甘緩之，血足可來養筋			
針灸處方：			
中藥處方： 1桂枝二錢 白芍四錢 炙甘草三錢 生薑二片 大棗十枚 柴胡三錢 伸筋草三錢 女貞子三錢 延胡索三錢 續斷三錢 川芎三錢 當歸二錢 熟地二錢 遠志二錢 補骨脂三錢 玉金三錢　十付　九碗水煮成三碗，每天早晚飯前各一碗 2麥芽糖一罐　每次一匙麥芽糖入內沖服			
解說： 1伸筋草→全身、四肢抽筋、拘攣，四肢無法伸張 2.方中含小建中湯、四物湯			
備註：			

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2007/11/6			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LL	女	16歲，瘦	2008/08/25

來診原因：
回診。此人為Angel man

問診：
睡好
胃口上升，喜飯麵等碳水化合物。
喝水多
大便好
直立走的很好
手溫額溫
體力、肌肉皆好轉
喜光亮環境→陽回之現象
現在對很多事物都感興趣

脈診：

望診：
她現在對人的呼叫比較有反應了，且有點可以溝通了。她直立走路走的比上次又更好了。

特殊診斷：

耳診：

診斷：病人進步中，再用前方即可

針灸處方：

中藥處方：
同8/11方 再十付 九碗水煮成三碗，每天早晚飯前各一碗

解說：
今天她父親帶她來，問說她都沒有流汗。師云繼續吃前方，可吃到流出汗來。

備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/06			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LM	男	35 中等	2008/08/06

來診原因：呼吸急促，心悸，後背頸項痠，睡不沉，思慮重

問診： 睡不沉，思慮重。 小便一日二、三次，但量多，有汗。 飯後打嗝，腸鳴，屁多。 體力中等，無關節痠痛。 無口渴，喜冷飲 胃口好 大便每日行 雙足溫
脈診：脈沉緩無力->夏逢冬脈
望診： 1、舌診：淡白紅 2、眼診 ： 瞳孔反應不快，肝區太平整。
耳診：
診斷： 腎陰陽皆虛，治腎必治心
針灸處方： 委中，陰谷，天柱，大杼
中藥處方： 黃連兩錢，黃芩三錢，阿膠三錢(分三包烊盡)，白芍四錢，炮附子四錢，熟地三錢，澤瀉五錢，半夏三錢，粳米三錢，厚朴兩錢，代赭石三錢，生薑兩片，補骨脂三錢，桂枝四錢，炙甘草三錢，訶黎勒兩錢。 拾付，九碗煮三碗，早晚飯前服。
解說： 天柱會痠痛多為久病，腎陽不好。
備註：

倪醫師病案紀錄	初診日期：2008/08/12		
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LQ	男	年約40，中等身材略瘦	2008/08/12
來診原因： 因長期洗頭未吹乾又開車當風，導致左側偏頭痛；左邊額頭上方有一腫塊；左手手背及背後長塊狀皮疹搔癢。過去曾抱孩子閃到腰，腰背酸痛上下行。			
問診：（1）出汗：能流汗。 (2)手腳溫			
脈診：無			

望診：請病患將頭低下來，腫塊並未變大。
耳診：無
診斷： 頭風、濕在皮下、脂肪瘤
針灸處方:左額上腫塊報刺、百會、右合谷、右外關、左頭臨泣、左太陽透率谷、右俠谿、左右委中、左右陰谷、左腿膕中稍下方腰痛點(阿是穴)，左右腎俞
中藥處方： 麻黃二錢、杏仁二錢、薏苡仁三錢、炙甘草三錢、連翹二錢、川芎二錢、白附子二錢、僵蠶二錢、勾陳二錢、秦艽二錢、杜仲二錢、荊芥二錢 三付，每付六碗煮二碗，早晚飯前。
解說： 1皮疹是皮下有濕，外乾內濕用麻杏薏甘湯。如果病人不出汗加桂枝，能出汗用荊芥即可。會癢可加連翹、銀花。 2秦艽除督脈痛、杜仲除腰痛。 3額頭上的腫塊，如果低頭會變大就是血管瘤，不可報刺。 4膕中相當於腰，承山相當於魄(肛)門，可於此兩者之間找相對應之壓痛點，即阿是穴。 5頭臨泣專治眼珠後的痛(痛連目睛)，也可治膽經上的頭痛、 6川芎、白附子、僵蠶、勾陳皆治頭痛。 7白附子專治風吹就痛的頭痛。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/12			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LQ	男	年約40，中等身材略瘦	2008/08/15

來診原因：
初診主訴頭風、左邊額頭上方有一腫塊，以及皮疹搔癢。二診諸證皆改善。

問診：
病人諸證皆有改善。

脈診：脈浮洪

望診：左額上之脂肪瘤明顯消退

耳診：無

診斷：　頭風、濕在皮下、脂肪瘤

針灸處方：(同初診)
左額上腫塊報刺、百會、右合谷、右外關、左頭臨泣、左太陽透率谷、右俠谿、左右委中、左右陰谷、左腿膕中稍下方腰痛點(阿是穴)，左右腎俞

中藥處方：　(同初診方)
麻黃二錢、杏仁二錢、薏苡仁三錢、炙甘草三錢、連翹二錢、川芎二錢、白附子二錢、僵蠶二錢、勾陳二錢、秦艽二錢、杜仲二錢、荊芥二錢
七付，每付六碗煮二碗，早晚飯前。

解說：
1皮疹是皮下有濕，外乾內濕用麻杏薏甘湯。如果病人不出汗加桂枝，能出汗用荊芥即可。會癢可加連翹、銀花。
2秦艽除督脈痛、杜仲除腰痛。
3額頭上的腫塊，如果低頭會變大就是血管瘤，不可報刺。
4膕中相當於腰，承山相當於魄(肛)門，可於此兩者之間找相對應之壓痛點，即阿是穴。
5頭臨泣專治眼珠後的痛(痛連目睛)，也可治膽經上的頭痛、
6川芎、白附子、僵蠶、勾陳皆治頭痛。
7白附子專治風吹就痛的頭痛。
8脈浮洪是夏逢夏脈，正常。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2005/05/05			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LR	女	四五十歲　瘦	2008/08/07

來診原因：
此人有慢性盲腸炎，大腸頭破潰後行成一個包膜(pocket)，轉呈慢性腹膜炎。右下腹持續痛。

問診： 二天無大便。已有十天右下腹不痛且無灼熱了。偶有噁心，有脇下滿。
脈診：脈已不數了(代表沒炎症)，有點緊(代表pocket內有壓力)
望診： **1、舌診：** **2、眼診** :
特殊診斷：
耳診：
診斷：
針灸處方：
中藥處方： 大柴胡湯 4 ＋芒硝 1 100Caps 8x3 before meals
解說：1.倪師曰這個pocket裡會有宿便，因為她病太久了(十五年以上)，所以我們一直用藥清他的宿便，愈清pocket就會慢慢縮小，痛也會慢慢解除。 2.倪師曰此女寧可她下利都不可讓她便秘。 3.陽明證無噁心，少陽證才有噁心。
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2005/05/05			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LR	女	四五十歲　瘦	2008/08/14

來診原因：
此人有慢性盲腸炎，大腸頭破潰後行成一個包膜(pocket)，轉呈慢性腹膜炎。右下腹持續痛。

問診：　右下腹仍有點壓力，但比之前好多了，自知仍有一點傷口在。小便深黃。

脈診：關尺脈數有力

望診：
1、舌診：
2、眼診 ：

特殊診斷：

耳診：

診斷：　下焦仍有熱實

針灸處方：

中藥處方：
大黃三錢　　芒硝二錢(分二包沖服)　　桃仁三錢　　丹皮三錢
冬瓜仁三錢　　薏仁三錢　　炮附子三錢　　敗醬草三錢　　川芎三錢
鉤陳三錢
7 帖　　6碗水煮成2碗　　早晚餐前各一碗

解說：　倪師曰要慢慢清他的宿便而非用速攻蕩滌法

備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2005/05/05			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LR	女	約五十歲。偏瘦。	2008/08/21

來診原因：此女因慢性盲腸炎，師用大黃牡丹皮湯加減，腹痛大減。八月七日來診時因有嘔證且脇下滿，師予大柴胡湯加芒硝，八月十四日來診時自述右下腹仍有一點痛感，嘔證去，小便深黃，師予大黃牡丹皮湯與薏苡附子敗醬草合方加減。今日來診自述服藥後反而便秘腸鳴。

問診：
（1）大便：服藥之後，反而便秘。

脈診：脈洪大有力。

望診：無
舌診：黃厚

耳診：無

診斷：裏熱重

針灸處方：無

中藥處方：
一、大黃牡丹皮湯　　200粒膠囊，早晚飯前各十粒。
二、HT45(己椒蔞黃丸)一罐三兩、午餐前睡前各三十粒。
　　芒硝一罐三兩、每次服用HT45時，沖服二茶匙。

解說：
1.病家自覺腸間咕嚕有水聲，理應下利，反便秘腹滿，可知水不在腸中，而在腸外。是己椒蔞黃丸證。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/07			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LW	男	約六七十歲　瘦	2008/08/07

來診原因：
下背痛(師曰帶脈)
無胃口，排氣多，體重下降
倦怠，肌肉消失，牙痛，視力差
關節痛

問診： 睡尚好 一直口渴，喜冷飲 雙足冷 小便不頻尿 睡時身熱，不蓋被。
脈診：右脈洪大
望診： 1、舌診：淡黃濕 2、眼診 :左眼瞳孔反應慢，肺區有痰
耳診：
診斷： 濕入血脈中，脈大為癆症
針灸處方：
中藥處方： 桂枝三錢，白芍六錢，麻黃三錢，白朮三錢，炮附子三錢，炙甘草三錢，知母五錢，防風五錢，茯苓五錢。麥芽糖一罐，每服時加一匙入內，沖。五付，九碗煮三碗，早晚飯前服。
解說： 病人肌肉之津液喪失使肌肉看起來變小。水去了心肺系統導致脈大。 處方內含桂枝勺藥知母湯治癆症，小建中湯治病人胃口不好，苓桂甘棗湯去濕治帶脈痛。
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/07			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LW	男	61 中瘦	2008/08/14
來診原因：前診為肌肉萎縮，體力不好，診斷為癆症濕入血脈中。病人自述服前藥後，體力增加些，體重仍下降。服藥前三天大便稀，之後又回到硬如前。左下腹時痛，排氣出後痛即緩。			
問診：口渴喜冷飲。有噯氣。			
脈診：			
望診：雙手臂血脈縮小，體力增加些 1、舌診： 2、眼診 ：			
耳診：			
診斷： 血脈中濕，已排出部分。			
針灸處方：			
中藥處方： 同前方加厚朴三錢，代赭石三錢，淮山三錢，黃耆五錢。(注: 前方為桂枝勺藥知母湯治癆症，小建中湯治病人胃口不好，苓桂甘棗湯去濕治帶脈痛)			
解說： 大便由硬轉軟表示血脈中的濕已出，但仍有濕。 厚朴降腸之逆氣，代赭石降胃膽脾胰三焦之逆氣。淮山黃耆補氣。			
備註：			

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/07			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LW	男	約六七十歲。瘦	2008/08/21

來診原因：

下背痛(師曰帶脈)
無胃口，排氣多，體重下降
倦怠，肌肉消失，牙痛，視力差
關節痛

問診：　仍有兩碗藥未服，望診臥蠶明顯
睡覺每兩小時醒，11:30 , 2:00 , 4:00 , 5:30 醒
晚上上半身溫熱，膝以下自覺冷，手一直是冷的
口一直渴，喜冰飲
胃口好轉
體力好轉
大便一天2~3次，質硬
小便淡白清
不易出汗

脈診：脈浮稍數，重按即無

望診：
1、舌診：黃濕
望其手上脈(青筋)已有縮小

特殊診斷：

耳診：

診斷：　心陽不足，心包積濕，脾陽不振，無陰實之證

針灸處方：

中藥處方：　同 2008年8月7日方加生附子二錢(另包)　乾薑二錢
天花三錢　　熟地二錢　　黃連二錢　　厚朴三錢
5帖　9碗水煮成3碗　早晚飯前各喝一碗

解說：　1.病人一直瘦下去，照理說寒證才會瘦，可他又喜冰飲，所以喜冰飲是假象
2.照理說舌苔黃應該用生地，但他下焦寒故用熟地。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LY	女	37歲	2008/08/08

來診原因： 之前曾來求嗣，服藥後有懷孕但後來流產。此次前來希望調好身體以求嗣。
問診： 少腹最近幾天隱脹滿，自覺與月經無關，月經下週來。雙足溫中等。足後跟痠痛。睡不好，多夢。大便二三天一次，成形。胃口好。口渴有喜室溫飲。小便顏色沒注意。
脈診：脈洪浮無力
望診： **1、舌診：**淡黃薄白 **2、眼診**：
特殊診斷：
耳診：
診斷： 虛熱　心血不足
中藥處方： 黃連二錢　黃芩三錢　白芍六錢　阿膠三錢(分三包烊盡) 熟地二錢　澤瀉三錢　山茱萸三錢　淮山藥三錢 丹皮三錢　茯苓三錢　補骨脂三錢　川芎三錢 梔子三錢　茜草三錢　當歸二錢 服時加生蛋黃一只　10帖　9碗水煮成3 碗　早晚餐前各喝一碗
解說： 1.多夢乃心神漂浮，神不藏，心中那滴血不足以藏神。 2.此方吃到下次月經結束 3.此方內含活血化瘀藥，因為患者述上次流產後來的月經過了七天還未淨 4.虛熱時月經來了吃阿膠不會止血。
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
LY	女	37岁 瘦	2008/08/21 傳真回診

來診原因：服前药后

左头及左颈肩背酸痛，手指节、脚指节不时地隐隐胀痛，后脚跟疼痛
手臂疼痛，自觉是骨头痛
胸口有时闷闷的
睡时会严重地磨牙，咬得很紧
时有口臭
舌头不时觉得燥、干
月经昨天（第5天）结束，断得很干净，月经时没有什么血块，以前经期都是25~27天，流产后，现在都是28天。

問診：
睡眠：很不好，没有睡意，很难入睡，睡时很短
排便：每日一、二次，有时成形，有时散状，一两次有腹痛，色黄
排尿：每天约7~8次，色淡黄。
胃口：还好
口渴：喜欢温热饮料
双手足：手冷有好转，仍手冷额温，手掌色淡红；足趾冷，足底温度适中。
体力：一直很疲劳

脈診：不詳

望診：

1、舌診：自述淡黄白

2、眼診 ：

中藥處方：
桂枝 五钱 白术 五钱 炮附子 三钱 炙甘草 三钱 补骨脂 三钱 巴戟天 三钱
泽泻 三钱 熟地 二钱 细辛 二钱 乌药 三钱 枳实 三钱 厚朴 二钱
党参 二钱 栀子 三钱 酸枣仁 三钱 知母 三钱 茯苓 三钱 川芎 三钱
當歸 三錢

拾付 9—3碗 早晚餐前服

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2006/09/07			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
MI	F	身形胖壯	2008/08/12
來診原因：			

身重且腫，早上都很累。
右側腹痛，自認來自卵巢痛。
經前乳房脹滿，易噁心、泛酸；經期很短，一天淨，經後則諸症改善。
口中酸味重。

問診：
胃口過佳。
大便秘（但服漢唐-33時則排便順暢），不排氣。
小便中黃。
口渴，喜冷飲。
雙足溫。
易出汗。

脈診：細小無力。

望診
舌診：黃乾。

診斷：有水腫，心陽不足，水氣不散，故身積水氣。

中藥處方：
（1）麻黃三錢 炮附子三錢 細辛二錢 桂枝五錢 白朮三錢 茯苓五錢
豬苓三錢 澤瀉五錢
十帖，九碗煮成三碗，早晚餐前各服一碗
（2）續服HT-33 澤蘭丸。

解說：
本病患身形胖壯，但心陽不足，故心臟無法負擔正常狀態下的身體功能運作，水氣因此容易蓄積而衍生諸症，就好像以較小的引擎驅動較重的車輛一般吃力。該現象也可從病患自述經過身體按摩推拿後自覺輕鬆、諸症改善的現象得到證明。
至於病機的演變過程，乃因心陽不足、往上到肺的熱能不足，使肺陽也跟著不足；肺因而無法把藏於其中的水氣往下順暢送至腎，積於中焦則發噁心、泛酸。乳房中的奶水也因心肺陽虛而聚於乳房局部，導致乳脹明顯；小腸熱量受心陽虛影響也不足，僅少量奶水能下降經小腸熱量處理而出，故經期僅來一天即淨。而因病患能出汗，故僅覺身體腫脹感，而沒有真正產生明顯水腫。
方義：本病患的脈象屬少陰證，但問診所得內容皆類似大柴胡湯或大承氣湯之相關症狀，因此倪師以麻黃附子細辛湯治療少陰證，並以五苓散將水濕排出；同時兼以HT-33處理中焦濕熱過盛兼便秘的問題。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：

姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**
MI	女	中年, 肥胖	2008/08/25

來診原因：
倦怠，水腫。

問診： 服藥反應：服前方如一碗， 則身體好，但會頭痛。如服半碗，則頭痛少，但身會腫些。 月事：月經明天要來了。 視力變差。
脈診：脈仍細小，較原先大些。
望診： 1、舌診： 2、眼診：
耳診：
診斷：
針灸處方： 同前。加攢竹。
中藥處方： 下次改處方時，增加 川芎三錢， 白附子三錢， 僵蠶三錢。
解說： 1. 視力變差 因太多水在經脈周圍。
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
MI	女	中年, 肥胖	2008/08/26
來診原因： 倦怠，水腫。			
問診： 病人好許多。			
脈診：			
望診： 1、舌診： 2、眼診：			
耳診：			
診斷：			
針灸處方： 同前。加太陽，　左血海。			
中藥處方： HT-64　　早晚飯前各服 40粒			
解說： 左血海→右少腹痛經。 HT-64 →(溫經湯加減)。			
備註：			

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
MJ	男	40餘歲，中等	2008/08/08
來診原因： 甲狀腺腫在長期服藥中，另因PSA值高踞不下懷疑是攝護腺癌。			

問診： 1.胃口：好但不吃太飽。 2.口渴：不渴。 3.大便：日一行。 4.睡眠：每晚睡四、五小時。 5.易汗否：難汗。 6.體力：時好時弱，自覺不差。 7.手腳：足溫。 8.小便：淡黃色，夜尿一、二次，已有改善。
脈診：洪大， 為夏脈 ，重按則無，並非附骨脈 ，屬正常。
望診： 1、舌診：淡紅濕舌。 2、眼診 :
特殊診斷：手掌皮乾 。髮微白、稍掉頭髮。
耳診：
診斷： 濕熱在下焦，導至發炎，今PSA值高，並非攝護腺癌。
針灸處方：
中藥處方： 豬苓三錢，滑石六錢，澤瀉六錢，白朮三錢，黃芩三錢，黃柏三錢， 烏藥五錢，細辛二錢，麥冬三錢，天花粉三錢，側柏葉三錢，當歸二錢， 何首烏五錢，海藻三錢，補骨脂三錢 五帖 12碗水煮成4碗 早晚飯前各一碗
解說： 如無癌之寒熱表徵或附骨脈，即使PSA高至8，亦非攝護腺癌。因濕熱困於下焦不出，致發炎，故以豬苓湯攻小便。又因小便無血，故去阿膠不用。另加黃芩、黃柏清下焦熱。經此攻法，混濁當隨尿而出。又因尿頻，用烏藥、細辛導心火至下焦。手掌乾，故用麥冬、天花粉以潤肺。海藻以處理甲狀腺腫。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/08			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
MJ	男	55歲，中等	2008/08/18

來診原因：
覆診：甲狀腺腫在長期服藥中，另因PSA值高踞不下懷疑是攝護腺癌。

問診：
１.胃口：尚好但不吃太飽。
２.體力：自覺過去一週體力增強。
３.手腳：足溫。
４.小便：　夜尿仍有一、二次，一週來並無改善。

脈診：

望診：
1、舌診：
2、眼診 :

特殊診斷：

耳診：

診斷：

針灸處方：

中藥處方：　同8/8方加巴戟天三錢
今日方如下:豬苓三錢，滑石六錢，澤瀉六錢，白朮三錢，黃芩三錢，黃柏三錢，
烏藥五錢，細辛二錢，麥冬三錢，天花粉三錢，側柏葉三錢，當歸二錢，
何首烏五錢，海藻三錢，補骨脂三錢，巴戟天三錢
　　五付　　12 碗煮成 4 碗　　早晚餐前各一碗

解說：
已服豬苓湯以利下焦濕熱，但仍未利出來。原方已有補骨脂以強腎，今再加巴戟天進一步強腎，令夜尿減少。

備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/07			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
MK	女	～50，微胖	2008/08/22

來診原因：
腎臟病復診。Creatine指數下降了。

問診： 無頭昏噁心了 皮膚不癢了 胃口好 更年期身熱退了 大便不規則，時利 小便意強量好 雙足溫 身體溫熱許多
脈診：細
望診： **1、舌診：**舌苔白濕，略帶淡黃 **2、眼診**：腎陽反應尚好，肝區仍有破洞
診斷：裡寒仍有
中藥處方： 同8/7處方 再4付 8/7處方： 生附子三錢，乾薑二錢，炙甘草三錢，澤瀉六錢，豬苓三錢，茯苓五錢， 當歸三錢，桂枝五錢，白朮五錢，半夏三錢，吳茱萸二錢，側柏葉四錢， 炮附子四錢，生薑二錢，川芎三錢，丹皮三錢，柴胡三錢，鬱金三錢
解說： 治腎臟病的關鍵是在治心（水剋火）。四逆湯就是治心陽的處方。
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
MK	女	～50，微胖	2008/08/29

來診原因：
腎臟病復診。仍有一付未煮。

問診：
本周服前方1小時後出現胸悶
睡：仍不好，仍有盜汗皮癢，仍不易入眠
大便：正常，每日行，但不多
小便：淡黃，無泡沫，尿意強，小便力量大
足溫
汗：有汗出了→心臟功能在恢復中

脈診：無力、緩

望診：

1、舌診：後布舌苔白濕厚，前部淡粉紅，有牙痕

2、眼診 ：右瞳孔對光反應好，左瞳孔對光反應較慢→左腎功能不如右腎

診斷：進步許多

中藥處方：
同8/7處方 再2付，煮法一樣，但是服用的量減半，早晚餐前各服半碗
8/7處方：
生附子三錢，乾薑二錢，炙甘草三錢，澤瀉六錢，豬苓三錢，茯苓五錢，
當歸三錢，桂枝五錢，白朮五錢，半夏三錢，吳茱萸二錢，側柏葉四錢，
炮附子四錢，生薑二錢，川芎三錢，丹皮三錢，柴胡三錢，鬱金三錢

解說：
方中有生附子、炮附子，病人本周在服藥時會出現胸悶的現象，說明她對附子的需求量降低，也就是說裡寒減少許多，病情在好轉中。

備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/06			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
MM	M	體重175磅 身高5’9’ 六十歲	2008/08/06

來診原因：一週半前切片發現直腸癌。

問診： １大便稀，同時吃西藥通便。有時鮮血混合大便，有時純血出來。喝可樂，吃麥當勞則便秘或下利。 ２肛門出血，一週前上了（切片之前即出血） ３小便淺黃 ４雙足冷 ５胃口好 ６口渴有，冷飲 ７睡皆好
脈診：脈緩有力
望診： **1、舌診：**舌淡黃紅 **2、眼診**：
特殊診斷：手冷，皮潤。
耳診：
診斷： 腸中寒熱並結。醫囑停止任何油炸食物，此為病因。
針灸處方：
中藥處方： 炮附子五錢　黃連二錢　黃芩三錢　黃柏三錢　麻子仁三錢　大黃三錢　丹皮三錢　茜草三錢 拾付　九碗煮三碗水　早晚飯前各一碗
解說： 1.茜草入血分故用，桃仁入氣分。大黃攻堅。 2.他之前有出血，雖然現在血止了，但仍要用活血藥活血化瘀。 3.他喜歡吃油炸食物，體內有溼熱故用三黃瀉心湯。
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/06			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
MM	M	體重175磅 身高5’9’ 六十歲	2008/08/20
來診原因：服前方後回診。			
問診： １大便三四次一天。 ２有二次看到一點血，混在大便中。 ３雙足溫（不覺冷） ４喜冷飲 ５睡時身冷 ６小便淡黃到中黃 ７睡皆好 ８直腸沒有痛感，也沒有灼燒感 ９掌冷額溫			
脈診：尺脈浮有力，附骨			
望診： 1、舌診：舌淡紅，濕，舌體大 2、眼診 ：			
特殊診斷：			
耳診：			
診斷：病人尺脈仍數有力，為裡熱仍有			
針灸處方：			
中藥處方：同前方，去麻子仁不用，400 caps　8x3　三餐飯前服用			
解說： １原方有效則效不更方，藥太苦故改成膠囊，大便次數過多故去掉麻子仁。 ２腸癌位在降結腸者，開刀後易轉移成為肝癌。位在直腸肛門位者者，開刀後易轉移到肺癌。			
備註：			

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/12			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
MM	女	54 歲，略胖	2008/8/12
來診原因：體力差，一直餓，過胖，今年增重25磅。			

問診： 睡眠：好。 胃口：好，喜甜食。 大便：每日行。 口渴尚好，喜温飲。 雙足冷冰。 不易流汗。
脈診：稍數無力
望診： **舌診：**黃乾。 **眼診　：**瞳孔對光無反應→腎陽不足。
診斷：　上熱下寒，腎陽不足致體力差。
中藥處方：　石膏五兩　知母五錢　防己三錢　茯苓三錢　澤瀉四錢　炮附子三錢　細辛二錢　黃連二錢　黃芩三錢　補骨脂三錢　敗龜板二錢　生地二錢 五付 9—3碗 早晚餐前各一碗
解說： 石膏五兩　知母五錢　防己三錢　茯苓三錢　澤瀉四錢→老師的秘密減肥方☺。 炮附子三錢　補骨脂三錢→補腎陽。 生地二錢→補腎陰因舌苔黃，若苔白用熟地。 敗龜板→陰陽俱補 澤瀉四錢→補腎時常用以利水。 黃連味苦，入心以補心 倪師曰:若患者精神體力尚可補腎就用補骨脂、澤瀉、熟地即可。若體力不好，腎臟功能很差了，就要用敗龜板、補骨脂、炮附子來補腎。弱欲補腎精、增加男人的精子就要用菟絲子、覆盆子。
備註：熱藥冷服。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/12			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
MM	女	約五十歲 肥胖	2008/08/19

來診原因：
體力差，一直餓

問診：
口渴尚好，喜溫飲
嗜甜食
大便每日行
雙足冷

脈診：脈稍數無力

望診：
1、舌診：
2、眼診 ： 瞳孔對光反應差→腎陽不足

診斷： 上熱下寒，腎陽不足

中藥處方：
石膏五兩　知母五錢　防己三錢　茯苓三錢　澤瀉四錢
炮附子三錢　細辛二錢　黃連二前　黃芩三錢　補骨脂三錢
敗龜板二錢　生地二錢
熱藥冷服　x 5 帖　9碗水煮成3 碗　早晚飯前各喝一碗

解說： 1.此人腎陽不足故他體力差
2.補骨脂偏於補腎陰。若患者精神尚可則用補骨脂及熟地即可。若體力不好，腎很差了就要用敗龜板、炮附子、補骨脂。
3.菟絲子、覆盆子用於補腎精、男人的精子。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/06			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
NK	男	25岁 瘦小	2008/08/08

來診原因：
服前药后，仍有胃痛，大便色黑；小便淋沥不尽，遗精，痔疮出血

問診：
睡眠：好

胃口: 差，无食欲，时有恶心

大便：每日行，色黑

小便：黄

口渴：有

手足凉

脈診：脉弦数

望診：

1、**舌診：**淡黄白，边见牙痕

2、**眼診**：

特殊診斷：

耳診：

診斷： 胃穿孔出血（口服抗生素所致），淋病

針灸處方：

中藥處方：黃土湯

熟地二钱 黄芩三钱 白术三钱 阿胶三钱（分三包烊盡）炙甘草三钱 灶心土五钱

炮附子三钱 滑石六钱 泽泻三钱 黄柏三钱 乌药五钱 龙骨五钱 牡蛎八钱

土茯苓四钱 大黄二钱 陈皮二钱 厚朴二钱 草果三钱 赤小豆四钱 当归二钱
槐花三钱 拾伍付 9-3碗，每日早晚餐前服

解說：

1 阿胶、炮附子→固阳止血，

2 熟地、白术→健睥，补血

3 灶心土→补胃穿孔出血处

4 大黄、黄芩、黄柏、土茯苓、泽泻、滑石→清利下焦湿热，土茯苓为治淋病要药

5 龙骨、牡蛎→潜阳涩精，止遗精

6 草果、陈皮、厚朴→開胃助消化，草果善化肉食

7 赤小豆、当归、槐花→疗痔疮

姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
OM	女	49歲, 中等身材	2008/08/28

來診原因：
去年10月至今洗腎。之前有冒眩及倦怠。

問診：

胃口： 好。

大便：不正常，隔日一行。

小便：淡白。小便便意不強，力量還好。一天4次。量不好。

口渴：尚好。

雙踝腫。

身冷多。

出汗：有一點汗，很少出汗。

雙足溫度：雙足冷。

月事：4年前更年期已過。

睡眠：睡尚好。洗腎前一天無法睡。

血壓：平均190/110。

有心悸。

脈診：脈洪大有力，中空→芤脈，心真臟脈。

望診：

1、**舌診：**白厚濕。

2、**眼診：**

診斷：血虛，腎衰竭。

中藥處方：
生附子三錢 乾薑二錢 炙甘草三錢
桂枝五錢 白朮五錢 茯苓五錢 豬苓三錢 澤瀉五錢
當歸二錢 木通三錢 細辛二錢 烏藥四錢 補骨脂三錢 巴戟天三錢
5付 9碗 →3碗 早晚飯前各服 1碗

解說：
1生附子 乾薑 炙甘草 → 壯心陽。
2桂枝 炙甘草 → 心動悸。

3細辛 烏藥 → 下焦寒，尿意不強。尿意更弱則加炮附子。細辛加烏藥可治頻尿與小便不利
4桂枝 白朮 茯苓 豬苓 澤瀉 → 五苓散 → 利尿
5倪師欲開四逆湯但方中有炙甘草，可是患者有水腫，因此用不用炙甘草曾一度斟酌，於是問患者有無心悸，患者答有，於是倪師決定保留炙甘草。
7 補骨脂 巴戟天 → 補腎陽。

倪醫師病案紀錄	初診日期：		
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
PK	女	約35歲，中等身材	2008/08/05
來診原因： 自述全身都不對勁			
問診： 做什麼都不對(但也對) 吃什麼都不對(但也對)			
脈診：脈緩			
望診： 1、舌診： 2、眼診 :			
特殊診斷：			
耳診：			
診斷： 百合證			
針灸處方：			
中藥處方： 百合八錢 知母五錢 生地五錢 五付 六碗水煮成兩碗，每天早晚飯前各一碗			
解說： 心理因素造成生理上的不適→百合病			
備註：			

倪醫師病案紀錄	初診日期：2008/08/13		
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
PL	女	11岁 瘦小	2008/08/13
來診原因：			

其母诉，患儿自幼体弱，身体瘦小，皮肤较黑，好动
两眼视力不平衡（师云：此与长时间躺着看书有关）

問診：

睡眠：睡觉好，一觉到天亮
二便：大便时有时秘，小便淡黄
食欲：胃口还好
口渴：口渴尚好，有时要冰有时不要
汗：　有时有汗
手足温度：足冰冷的，手凉额热
肌肉：有时肌肉酸痛

脈診：脉稍数、一息六至

望診：

1、**舌診：**淡黄湿

2、**眼診**：

診斷：　下焦寒、阳热反逆上头

中藥處方：

麦冬2　党参2　细辛1　乌药3　炮附子2

白芍3　栀子1　麻子仁1　桂枝1.5　白术1

炙甘草 1　　200 粉　三餐前一茶匙

解說：

手凉额热、足冰冷的→下焦寒、阳热反逆上头

大便时有时秘→小肠冷，以“细辛 乌药 炮附子”升小肠温度

肺主静藏魄，主忧。肺燥则人燥动，在小儿则多动，以“麦冬 党参”润肺

桂枝、白芍→调和营卫

桂枝、白术→行阳利中焦湿

栀子→清虚热

麻子仁→润肠通便

倪醫師病案紀錄　　初診日期：

姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
VM	男	約40歲，體壯	2008/08/21

來診原因：
回診，服前方(8/6)後，臉色黑較退。

問診： 服前方(8/6)後
嘔心只有一點點，比以前好
小便很強，小便意強
無昏睡
大便正常
胃口好
雙足溫
反應(陽舉)很好

脈診：腎脈

望診：
1、**舌診：**淡紅(8/6舌診為淡白黃，故病退中)
2、**眼診** ：腎區反應比以前好了

特殊診斷：

耳診：

診斷： 進步中

針灸處方：

中藥處方： 同前方用 600粉量　三餐前各三茶匙

解說：1. 師云：秋天見冬脈(腎脈)，預後佳
2.尿毒症者若不頭暈噁心就沒危險。尿毒症有噁心頭暈者要用黃連解尿毒。

備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/06

姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
WM	F	58，身材中等	2008/08/06

來診原因：1.因前一陣子檢查子宮有發現異常細胞，西醫欲切片進一步確定。
2.睡眠一直不好，曾以中藥治療後有改善。
3.易嘔吐，且暈眩嚴重。（幾個月發生一次嚴重暈眩，嘔吐後改善）
4.大便時見清穀（裡寒）。
5.右肋時痛。
6.記憶力差。

問診：1.頻尿，且小便無力。 2.口苦。 3.口渴，喜溫飲，飲多。 4.頭面惡風、發麻，左臉也麻、惡風。 5.右眼易流淚。 6.正常出汗。 7.雙足易冷。 8.已停經2年。
脈診：脈沈無力。
望診： **1、舌診：**淡紅，兩側齒痕。（病患自述晨起白苔） **2、眼診** :右瞳孔見光後略縮小隨即又擴大，肝區無正常紋路、較平整。
特殊診斷：小腿膽點有壓痛→膽結石。
耳診：耳穴膽點有壓痛→膽結石。
診斷：右腎功能仍差（病患過去有此病史）、雙肩足少陽經循行處疼痛、膽結石。
針灸處方：雙合谷、百會、左地倉透頰車、雙太陽、雙太衝、雙曲池（合谷太衝開四關導引氣機，其餘穴位處理頭面問題）、雙足三里、右膽石點（膽結石）、雙睛明（流淚）。
中藥處方： 黃連二錢 黃芩三錢 白芍五錢 阿膠三錢（分三包） 炮附五錢 乾薑二錢 吳茱萸三錢 白朮三錢 烏藥五錢 細辛二錢 黃耆五錢 桂枝五錢 炙甘草三錢 大棗十枚 生薑三片 柴胡三錢 枳實三錢 五倍子三錢 海金砂三錢 ×10帖 9碗煮成3碗，早晚餐前各服一碗 HT-14治膽結石方，2罐六兩。早晚餐後各服40粒 大黃三片，每日一片，泡熱水喝。

解說：1.本病患為華人婦女，身形中等略瘦，自述經常因自我要求高但做不到而很不開心、焦慮。
2.故處方中以黃連阿膠湯處理睡眠問題（無失神故不加蛋黃），炮附乾薑溫中固表，吳茱萸止嘔，烏藥細辛治療頻尿，另合桂枝湯調和營衛治療惡風，四逆散加五倍子、海金砂治療膽結石。去膽結石從大便出，用白朮去濕不用茯苓以免造成濕自小便出，處方的方義是希望濕自大便出 3.右眼易流淚乃濕熱所致，以大黃泡熱水取其氣，治療目部濕熱。 4.膽結石平時可多吃酸味食物，如醋。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/14

姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
WP	女	50岁 中等瘦小	2008/08/14

來診原因：

服前药后无咳嗽了。右肩后方到腋，再到前肋下，仍有时痛，（自认为有可能是因为之前有装管子排出水后管子造成的痛），有恶心感，平时白天时两肋有紧胀感（该患者为乳癌移转骨，乳癌已治好，骨痛仍有）

問診：

睡眠：常在凌晨2:30醒，能很快回睡

晚上睡时温度很好，無特殊寒熱

二便：大便每日一、二次，小便淡黄
胃口：还好
口渴：稍有一点口渴
双足：温
体力：好

脈診：脉稍洪大，一息6-7至

望診：

1、舌診：淡黄红

2、眼診：

中藥處方：

桔梗5	炙甘草2	补骨脂3	续断3	炒麦芽3
当归3	川芎3	金铃子3	延胡索3	熟地2
柴胡3	玉金3	黄芩3	党参3	生姜3

炮附子4 桂枝3 白芍6 茯苓3 海藻5

牡蛎5 枳实3 代赭石3 旋覆花3 泽泻6

猪苓3 800粒 每服8粒，三餐前服

汉唐60号六两 每服8粒，三餐前服

解說：

汉唐60号→收敛静脉。

倪醫師病案紀錄	初診日期：2007/10/01		
姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**
WY	F	43歲，略矮胖	2008/08/18

來診原因：

病史：腦瘤。2005年手術切除，但2007年1月復發，又切除90% 腫瘤，但又反覆變大。左半身肢體會麻，時抽筋，有昏倒現象。後背第五椎壓痛，腰部帶脈痛。經期七天，時停時拖幾天，來很準時。

服藥後近期左半身肢體麻較過去改善，經前及緊張時麻較明顯。左肩痛時亦有發麻感。

問診：

睡眠尚好。

大便每日一次。

有一點口渴，喜熱飲。

胃口好。

經期準時。（病患有服HT-2退奶丸）

雙足溫，手溫額涼。

脈診：

望診

舌診：淡白紅。

特殊診斷：第五椎壓痛減少。

診斷：

中藥處方：

2008/05/28處方繼續再服。

解說：

本病患居住於香港，自初診至今共就診四次，分別為2007/10/01、2007/10/03、2008/05/28及2008/08/18。倪師指出，女性之腦瘤成因，乃由於心火不足造成奶水逆流入腦而成，故若能使奶水正常轉化為月經而排出，腫瘤細胞在無法持續得到養分的情況下就會慢慢縮小。因此本病患治療的重點在於通便、強心、治月經。

初診、二診處方：

(1)噴鼻粉（麝香礬石散）　一日噴一次

(2)茯苓五錢 桂枝三錢 炙甘草三錢 大棗 十枚 小麥五錢
艾葉二錢 當歸二錢 川芎三錢 熟地二錢 白芍三錢
龍骨三錢 牡蠣一兩 生附子二錢（另包）
12帖，9碗水煮成3碗，早晚餐前各服1碗

(3)多服蔗糖水以緩和抽筋。

方義：麝香礬石散能使腦部因腫瘤而產生的水腫消退，使積水從鼻竅流出，以阻斷腫瘤之水源。苓桂甘棗湯治帶脈痛。甘麥大棗湯可治療抽筋，芎歸膠艾湯去阿膠以調理月經。龍骨牡蠣潛陽，牡蠣亦能軟堅。生附子強心陽，去裡寒（以上說明及當時相關問診內容尚可參FTP站中「倪師臨床醫案4」講義夾中W君BRAIN TUMOR.doc）

2008/05/28回診病情有較和緩，第五椎壓痛比上次輕很多，左側臉麻在經前加重、經後減輕。倪師以初診原方加入黃耆五錢補氣行氣、勾陳四錢治療頭痛，瓦楞子五錢治療頭部腫瘤。同時讓病患在經前一週及經期間服用HT-2（退奶丸），30×2，早晚飯後各服1次。續用噴鼻粉。

★補充說明：瓦楞子外型既似乳房側面，也像頭部，可用於兩種時機。一是乳房腫瘤硬塊合併有傷口流濃時，要加入處方中與牡蠣配合重用，劑量在五錢以上。另一種情況則用於治療頭部腦部之腫瘤。

2008/08/18效不更方，持續服用；但噴鼻粉先停用（病患使用後鼻乾、鼻塞）。

★補充說明：當病患使用麝香礬石散後，會有鼻水或大量分泌物，要將之擤出咳出不要吞入。一旦開始出現使用後鼻乾、鼻塞時，表示鼻腔、腦部及相關孔竅已經沒有多餘的水分了，藥物僅讓鼻腔產生充血狀態而已，此時就可停止使用。

備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/05

姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**
XJ	男	10歲　瘦	2008/08/05

來診原因：

扁桃腺腫大。胃口不好，挑食。皮膚乾燥。睡時出汗(正常)。大便每日行。

問診：
脈診：
望診： 1、舌診：淡白紅 2、眼診 :
特殊診斷：
耳診：
診斷：上焦一點溼熱
針灸處方：
中藥處方： 喉蛾方　一罐 6 兩　三餐後二茶匙 麻杏苡甘湯　一罐 6 兩　三餐前二茶匙 夏枯草五錢　一包備用　　煮蛋　兩碗煮成一碗　在扁桃腺沒腫大時喝同時把蛋　吃掉，可以終生預防扁桃腺腫大
解說： 倪師曰小兒乃純陽之體，睡覺時出些汗是正常，人在睡覺時陽氣由外進入陰裡面，此時汗孔會比較開，小兒陽氣旺因此會出點汗，這是正常。但若夜裡盜汗伴驚叫就要治療了。
備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/14			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
YA	女	10歲，瘦	2008/08/14
來診原因： 瘦小，不喜吃飯。			
問診： 胃口好(小孩說自己胃口好，父母說不喜吃飯) 大便每天有 足熱 口渴有，想喝溫飲 睡好 體力好 有汗出，易感冒，感冒時不喜吹風 早起時打噴嚏			
脈診：稍數			
望診： 1、舌診：淡白紅 2、眼診 : 左眼肝區左下處有白點			

特殊診斷：
耳診：
診斷： 中焦寒濕
針灸處方：
中藥處方： 1桂枝二錢 白芍四錢 炙甘草二錢 生薑二錢 大棗十枚 十付 六碗水煮成兩碗，每天早晚飯前各一碗 2麥芽糖一罐 每次加一匙入內沖服
解說： 早起時打噴嚏→表虛
備註：

倪醫師病案紀錄	初診日期：2008/08/18		
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
YH	F	83歲 過胖	2008/08/18

來診原因：

１帕金森氏症，近三個月發現。病後走路腰挺不直→陽虛。

２發病前，長年（十年以上）服用多種西藥、營養品，包括：

a baby aspirin b 高血壓藥 c 頻尿藥 d 善存多種維他命 e 骨骼維他命 f 女性荷爾蒙 ……族繁不及備載。

３不吃高血壓藥時的血壓：150/90→此數值多是腎臟問題，血液流入腎臟，血管擴張不易，壓力回逆造成高血壓，不吃高血壓藥不會中風。若一定要吃，160/100以上才吃藥。

４不聞香臭→此為女性荷爾蒙造成的副作用。

問診：

１睡不好，晚上小便三次，冬天可達九次。

２大便秘，五天以上才有，不吃藥不大便。

３小便茶色因服維他命。

４口渴平平，欲飲溫水。

５胃口好。

６雙足冷。

７早起口苦、舌乾。

８左手左足麻→有中風前兆的跡象。

９足有點水腫，靜脈曲張→重用白芍。

１０眠時身溫尚好。

１１很少頭痛。

脈診：洪有力，不數。

望診：下巴抖，手抖，閉眼則眼皮抖

1、舌診：舌黃濕

2、眼診 ：瞳縮反應差→腎陽不足。（瞳孔小→聰明）

肝區有白點→累積毒素。(服西藥過多) 肺區有點痰。
特殊診斷：
耳診：
診斷： 腎陽不足，肝損傷，陽明腑熱。
針灸處方： 1雙三皇穴→退水之外，對腳無力很有幫助。 2雙高血壓穴（足三里下五分往上刺到足三里）→可降血壓。 3雙合谷　雙迎香→ 治鼻不聞香臭。 4噴鼻粉→助痰飲排出。

中藥處方：
補骨脂三錢　澤瀉六錢　川芎三錢　丹皮三錢　桃仁三錢　茯苓五錢　烏藥五錢　細辛二錢　白芍一兩　炙甘草五錢　炮附子三錢　辛夷三錢　厚朴二錢　枳實二錢　大黃四錢　芒硝二錢（分三包沖服）　柴胡三錢　鬱金五錢　龍膽草三錢　酸棗仁三錢 三付　九碗煮三碗水　早晚飯前各一碗

解說：

１此為典型西藥營養品造成副作用之帕金森氏症。

２吃高血壓藥會利尿，於是得吃頻尿藥。Aspirin與維他命荷爾蒙皆無益處，更不可能預防骨質疏鬆症。故所有西藥都要停藥。不然帕金森氏症不會好。

３川芎、鉤藤、丹皮、桃仁皆可強壯血管，丹皮桃仁活血化瘀用在動脈，靜脈用白芍，服用以上中藥，即使血壓高達240也不會中風！

４此陽明腑熱證須先通大便解決便秘問題，之後始可著手治療帕金森氏症。

５走路彎腰，手抖，皆為陽虛陽不足之症狀。

６辛夷治鼻不聞香臭的嗅覺問題。烏藥、細辛引小腸火下行，促膀胱氣化，治療頻尿。

７每天針灸鞏固療效。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/18			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
YH	F	83歲　過胖	2008/08/22

來診原因：帕金森氏症針灸復診。
過去有打冬天老人流行性感冒疫苗→不可再打。

問診：
１服前方後一日有一次大便
２小便茶色→仍有宿便
３左腿仍有點麻木

診斷： 病人好轉中，但仍不可停藥

針灸處方：
１雙三皇穴→退水之外，對腳無力很有幫助。
２雙高血壓穴（足三里下五分往上刺到足三里）→可降血壓。
３雙合谷　雙迎香　雙外關→ 治鼻不聞香臭。
４雙太沖　右曲池　雙絕骨→以中風大穴治其左邊麻木。
５雙委中　雙陰谷

６雙承山→承山有肩膀承擔起一座山的意思，故雙腳無力下此穴治之。下針必針到骨上才有效果。

中藥處方：
１同8/18方：（補骨脂三錢　澤瀉六錢　川芎三錢　丹皮三錢　桃仁三錢　茯苓五錢　烏藥五錢　細辛二錢　白芍一兩　炙甘草五錢　炮附子三錢　辛夷三錢　厚朴二錢　枳實二錢　大黃四錢　芒硝二錢（分三包沖服）　柴胡三錢　鬱金五錢　龍膽草三錢　酸棗仁三錢）
十付　九碗煮三碗水　早晚飯前各一碗
２HT-99斑龍丸　六兩　30x2中餐前及睡前各一次三十粒

解說：
１吃aspirin造成的中風多是左側中風。此病患左側麻木已經接近小中風的症狀，因此加針中風穴治療。
２因督脈為諸陽之會，若腰直不起來，嚴重者連頸項都無力抬頭，則命在旦夕，三天內有危險！斑龍丸含有鹿角膠、鹿茸，為補陽氣最強的藥。病人上身過胖，雙腳無力，已呈現上實下虛的危險症狀。
３此帕金森氏症因西藥服用過多，痰涎堵在經脈上，造成手抖。要等到停用aspirin一個月以後，重建血管，不會隨便撞到就黑青，眼白中沒有血絲密布，變成淡青色的眼白，左邊身體不麻木，感覺跟右邊一樣或是跟原來一樣，走路比較有力氣，才可以使用吐法攻之。否則一旦採取吐法，血液大量往上衝，aspirin造成的血管破壞可能使病人無法承受而內出血中風。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：

姓名	性別	年齡及體型	來診日期
YL	女	～80，中等偏胖	2008/08/01

來診原因：

有輕微中風。左唇麻，左側無力。長期服用asprin。

問診：

1、**睡眠**：不好。

2、**胃口**：尚好

3、**大便**：每日行

4、**小便**：中黃

5、**口渴**：有。口乾嚴重。喜冷飲

6、**問汗**：有盜汗→表陽虛

7、**體力**：差

8、**其他**：有汗，時熱時冷，無噁心→仍在太陽表階段，未入少陽

脈診：脈大有力

望診：

1、**舌診**：淡黃濕

診斷：

中藥處方：小續命湯加減

麻黃二錢，桂枝三錢，杏仁三錢，炙甘草三錢→麻黃湯，又名“還魂湯”

當歸二錢，黃耆五錢，黨參?三錢→補氣補血

炮附子三錢→固表
麥冬三錢→生津止渴
石膏五錢→清裡熱
防風五錢→祛風
川芎三錢，丹皮三錢→活血化瘀

三付
9→3碗，早晚各溫服1碗

解說：

備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
YL	女	～80，中等偏胖	2008/08/06

來診原因：

有輕微中風。左唇麻，左側無力。長期服用asprin。

問診：

服上方後有無出汗？答：有一點
自覺很虛弱。睡眠較前好轉，仍有寒熱往來。
左側時麻時止，時有力時無力。
體力差
胃口無
大便每日行
早上有心痛徹背
口渴喜冷飲

脈診：脈洪時快時慢

望診：

1、**舌診：**淡黃
2、**眼診**：

特殊診斷：

耳診：

診斷： 心血不足。虛證中風，心氣受阻。

針灸處方：

中藥處方： **炙甘草湯**

炙甘草一兩　生薑兩片　大棗十枚　桂枝四錢　熟地三錢
阿膠三錢(分三包烊盡)　黨參三錢　麥冬三錢　枳實三錢
薤白三錢　瓜蔞實五錢
五帖　九碗水煮成三碗　早晚飯前各喝一碗

解說：

倪師把脈時發現她的脈洪時快時慢故知她心臟有問題，因此問他是否有胸痛，他說：「早上有心痛徹背」
心臟病不舒服若是心氣方面的問題則方中用枳實、薤白、瓜蔞實。

備註：

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/01			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
YL	女	年約七八十歲，中等身材，背微凸	2008/08/13

來診原因：

初診時長期服用Baby Aspirin導致輕微中風，左唇麻且左側無力，師先予小續命湯加減二劑，患者無大進步，二診時(2008/08/04)予炙甘草湯，病人服後狀況大有改善，依約來三診。脈仍時一止，但有力許多，體力、胃口、睡眠皆好轉，左側身麻已退，大便由便秘改善為日一行；心口痛減少，仍有一點點。

問診：

（1）體力：轉佳。
（2）胃口：轉佳。
（3）睡眠：轉佳。
（4）大便：日一行。
（5）其他：心口痛減少，仍有些微疼痛。

脈診：有時一止，但有力許多。

望診：舌苔淡黃

耳診：無

診斷：炙甘草湯證

針灸處方：無

中藥處方：

同二診方(2008/08/04炙甘草湯加減)，加川芎三錢。
予五付，每付九煮成三碗，早晚餐飯前服用。

解說：

1川芎可活血，可走到腦部，又可增加血管彈性，不像Aspirin反而會導致腦出血中風。
2炙甘草湯既然中病，就要守方。
3二診所開炙甘草湯並無攻下藥，連火麻仁都去掉了，但服後大便卻能暢行，這是因為心臟力量回復，進而使小腸蠕動速度加快，所以大便就因而通暢了。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/01			
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：

YL	女	年約70，中等身材，背微凸	2008/08/20

來診原因：

初診時長期服用Baby Aspirin導致輕微中風，左唇麻且左側無力，二診時(2008/08/04)予炙甘草湯，病人服後狀況大有改善。三診脈仍時一止，但有力許多，體力、胃口、睡眠皆好轉，左側身麻已退，大便由便秘改善為日一行；心口痛減少，仍有一點點。今日四診時自言大便甚多，日五、六行，頭痛與目眩皆去，但左手仍有麻感，脈節拍仍稍有不齊。

問診：

（1）體力：轉佳，但仍未全恢復。
（2）胃口：轉佳。
（3）睡眠：佳。
（4）大便：日五、六行。
（5）小便：淡黃
（6）手足：轉溫。
（7）其他：頭痛暈眩皆去，左手仍麻。

脈診：有時一止，但有力許多。

望診：舌苔淡黃

耳診：無

診斷：仍是炙甘草湯證，已進步許多。

針灸處方：無

中藥處方：

同八月六日方，加川芎三錢。
予五付，每付九煮成三碗，早晚餐飯前服用。

解說：

1川芎可活血，可走到腦部，又可增加血管彈性，不像Aspirin反而會導致腦出血中風。
2炙甘草湯既然中病，就要守方，且其左手麻未去，仍是血虛。
3所開炙甘草湯加減並無攻下藥，但服後大便卻能日五、六行，這是因為心臟力量回復，進而使小腸蠕動速度加快，就會自動排除腸中積糞。
4脈仍稍結代是因為小腸套疊，心血自腹主動脈下行時會受到阻礙，故心律仍不齊。

倪醫師病案紀錄	初診日期：2008/08/01		
姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**
YL	女	年約70，中等身材，	2008/08/27

		背微凸	

來診原因：

初診時長期服用Baby Aspirin導致輕微中風，左唇麻且左側無力，師先予小續命湯加減二劑，患者無大進步，二診時(2008/08/04)予炙甘草湯，病人服後狀況大有改善。三診時脈仍時一止，但有力許多，體力、胃口、睡眠皆好轉，左側身麻已退，大便由便秘改善為日一行；心口痛減少，仍有一點點。本次四診病人結代脈幾乎消失，排糞極多，手足溫熱，原本的左側無力已恢復正常，師再予十帖藥以鞏固療效，並囑可不用再來復診。

問診：

（1）體力：好。
（2）昏眩：已無。
（3）中風患側：全部恢復。
（4）大便：日一行，量極多。
（5）睡眠：好，睡時身溫。
（6）手足：皆溫，額涼。
（7）頭痛：已無。

脈診：右手脈微有代脈，左脈很好。

望診：苔黃濕。

耳診：無

診斷：病人進步很多，且穩定。

針灸處方：無

中藥處方：

同二診方(2008/08/04炙甘草湯加減)，加川芎三錢。
予十付，每付九煮成三碗，早晚餐飯前服用。

解說：

1川芎可活血，可走到腦部，又可增加血管彈性，不像Aspirin反而會導致腦出血中風。
2炙甘草湯既然中病，就要守方。
3二診所開炙甘草湯並無攻下藥，連火麻仁都去掉了，但服後大便卻能暢行，這是因為心臟力量回復，進而使小腸蠕動速度加快，所以大便就因而通暢了。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/07

姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
YP	男	～40，中等	2008/08/07

來診原因：

右膝蓋因踢足球受過傷，雙踝皆受傷。右肩偶爾痛。後腦枕骨位痛。鼻塞，流白涕。背部皮膚呈褐色、乾、且蛻皮，很癢。胸口也有。已多年。

問診：

胃口好
無寒熱的感覺

口渴尚好
大便每日行
小便黃色

脈診：脈緩有力

望診：

1、舌診：淡黃濕

診斷： 皮下積濕未退

針灸處方：
右膝五針→右膝痛；雙商丘透丘墟→雙踝痛；
左後溪，左申脈，右肩井，左足三里→右肩痛；
合谷，迎香→鼻塞；曲池→上半身止癢穴

中藥處方：
麻黃二錢，杏仁二錢，薏苡仁五錢，甘草二錢，連翹二錢，銀花二錢

大火煮，6碗水煮成2碗，早晚餐前各服1碗
21付

解說：
1.麻杏苡甘湯多用於皮下積濕造成的皮膚癢乾。因皮下積濕阻擋新的水取代舊的水，故皮膚會乾。麻黃發表；杏仁與麻黃相配，補足肺的津液，并滋潤肌膚；薏苡仁收皮下積濕。
2.連翹、銀花，質輕，走皮表，倪師常配與經方一起，治皮膚癢。

備註：

倪醫師病案紀錄 初診日期：2008/07/21

姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**
YS	F	46歲左右，中等身材	2008/08/04

來診原因：1.初診：飯後胃痛，兩邊卵巢腫瘤，子宮內膜異位。
2.前方服後胃痛減輕，時有痛（食後痛），服藥第一至二天瀉下多，之後正常，第七天起骨盆痛腰痛，之後左脾胰區（臍左部位）痛。一個月前病發時肩膀很痛。

問診：（1）大便黃。
（2）小便淡黃。
（3）手足冰冷，膝痛、足踝痛。
（4）口渴有，喜溫飲。
（5）夜間手足冷，肚熱，頻尿多、睡不好，上身熱，四肢冷。。
（6）胃口好（脾臟功能好），味覺好（胰臟功能好）。
（7）體力差倦怠。
（8）近期體重少10磅。

（9）仍有月經，一月一次。
脈診：稍數實有力。
望診 **舌診**：黃厚乾。
耳診：無。
診斷：
針灸處方：**前側**：雙後溪、申脈，右三陰交，雙公孫、內關，中脘，巨闕，關元，天突，雙足臨泣。**後側**：雙心俞、肺俞、腎俞、委中。
中藥處方：（1）7/21處方＋細辛2 栝簍實3 茜草3 丹皮3 單位：錢，9碗煮成3碗×10帖 （2）HT-8(b)

解說：

7/21處方為：旋覆花4 代赭石3 柴胡3 黃芩3 玉金5 半夏3 黨參3 生薑2片 枳實3 厚朴3 大黃2 麻子仁3 茯苓4 白朮3 當歸4 桂枝3 炙甘草5 杏仁4 川芎3 熟地2 白芍5 生附3 乾薑2

病患為中年華人婦女，胃痛的原因乃食用甜食引起。師云胃痛（甚至是胃癌）發生的原因經常與飲用咖啡及食用精緻白糖製造的食物有關。咖啡為酸性，精製、人工糖為小分子，能被體內細菌吞噬，產生的排泄物亦呈酸性；當體內環境酸性多於鹼性時胃酸自然較多，也容易胃痛，罹患癌症的機會也會大增。

腹痛辨證：斷續痛為虛證，持續痛為實證。

病患之肩膀酸痛主要是因為二尖瓣閉鎖不全（過去吃西藥造成之傷害），往上逆流之血液較多，肩部負擔較重引起。

5. 病患內踝上三寸（三陰交）按之痛甚→卵巢腫瘤。若治療後按之痛減或不痛表示腫瘤改善縮小。

6. 身體示意圖：

肺法象天，位居至高之位，心火肺炎上遇冷而下降。

心

胃寒時熱會上逆

胃

上肢　　心火下移於小腸　　上肢

小腸

膀胱

下肢　　下肢

心臟管動脈，主上肢正常溫度。同時心火能下移於小腸，小腸管靜脈，供應下肢正常溫度。心與小腸有同樣的速度、壓力與溫度。

因此，若小腸火不足，腹部溫度不夠，血循變差，則腸胃蠕動變慢，排便就會不通；同時卵巢子宮也可能產生腫瘤。而小腸火不足，也會導致位於小腸前面的膀胱裡水無法氣化，膀胱無法儲存一定體積的尿液，尿液稍增便會頻尿，且因氣化力量不足，導致噴出力量較弱，解尿會有不淨感。

同理可知，當下肢溫度變冷時，下肢血管中便可能有大小不等的clot產生，即是心臟病的前兆。

故本次處方中師加入細辛使小腸溫度增加，栝簍實配枳實處理心臟瓣膜閉鎖不全，茜草攻堅處理腫瘤（配生附開陰實效果更佳）。

針刺穴位解說：

後溪（通督脈）、申脈（通陽蹻），三陰交（壓痛點），公孫、內關（心胸相關疾病），中脘（胃有問題），巨闕，關元，天突（心三針，治療心絞痛，心痛徹背、背痛徹心），足臨泣（腰酸痛帶脈為病）。心俞（1.5寸針，五椎旁開一寸外斜刺）、肺俞（1.5寸針，三椎旁開一寸外斜刺，治心必治肺）。腎俞、委中（治療腰痛，水氣在腰間用腎俞，委中以旋轉及提插手法同用的方式做三次補瀉動作，做完後略提針如豆許→補法收尾）。

倪醫師病案紀錄	初診日期：2008/08/12		
姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
ZZ	女	35歲，很瘦。	2008/08/12

來診原因：

自認有憂鬱證，近來覺身發熱，時發頭痛，自覺從足心冷到膝蓋，左肩胛骨痛、左膏肓痛、後背痛(延足太陽上下痛，含帶脈)、左脅下痛、右腰後悶痛、月經後左下腹抽痛、自覺吸氣淺，只能到中脘附近，白帶嚴重、經痛、經常呃氣、胃酸反逆、臉上有乾蘚。大便不成形。

問診：

（1）寒熱：近來身覺發熱，時又頭痛。自覺從足心冷至膝。
（2）胃口：好，時又過餓
（3）大便：每日一次，黃褐。
（4）小便：黃
（5）口渴：尚好。
（6）睡眠：時好時壞。
（7）月經：白帶多，經來腹痛。
（9）其他：時噯氣(胃酸)、臉頰有乾蘚，退皮且癢

脈診：無

望診：

1、**舌診：**淡黃紅
2、**眼診** :無

耳診：無

診斷：真寒假熱

針灸處方：

中藥處方：

生附子二錢(布包)、乾薑二錢、炙甘草五錢
麻黃二錢、杏仁三錢、薏苡仁三錢、
當歸二錢、白芍五錢、鬱金五錢、黃芩二錢、遠志五錢、龍骨三錢、~~牡蠣五錢~~
桂枝四錢、茯神三錢

二付，每付九碗煮成三碗，早晚飯前。

解說：
1因此人易緊張，師開牡蠣五錢鎮驚，因病人吃素，去牡蠣改茯神。
2真寒假熱單用生附去裏寒即可，上熱下寒則要同時開去上熱及去下寒的藥。
3此女足冷至膝是裏寒，故用四逆湯。
4因裏寒盛，吸氣無法下降至丹田。
5自覺憂鬱且來診時易緊張，師用當歸、鬱金、黃芩、遠志、茯神等情志藥
6舌苔鮮黃，表示病淺，癌症病人舌苔黯或鏡面舌，難治。
7麻杏薏甘湯治皮蘚，能除皮下之濕。

倪醫師病案紀錄　　初診日期：2008/08/12

姓名	性別：	年齡及體型	來診日期：
ZZ	女	46歲，中等身材，偏瘦。	2008/08/15

來診原因：初診以憂鬱症為主訴來診，師診斷為真寒假熱，予四逆湯加減。三日後復來二診，自言足較溫，仍有頭痛、噯氣。惡寒，時頭暈，口渴喜溫飲，背痛兼帶脈痛。胃口不太好。月經快來了。臉上乾癬不癢但會脫皮。

問診：
（1）出汗：能流汗。
（2）寒熱：已無偶然發熱，感覺發冷。手冷額熱。
（3）呼吸：仍短氣。
（4）痛：帶脈痛及頭痛仍有，且時暈眩
（5）胃口：不好，仍有噯氣
（6）大便：每日一行
（7）小便：小便黃，量無增加

脈診：脈虛數，重按無

望診：無
舌診：紅乾。

耳診：無。

診斷：裏寒仍有

針灸處方：雙足臨泣、雙委中

中藥處方：
桂枝五錢、白芍五錢、炙甘草三錢、
當歸二錢、木通二錢、細辛二錢、大棗十個、
柴胡三錢、生薑二片、鬱金五錢、黃芩三錢、
遠志五錢、龍骨三錢、茯神三錢、茯苓五錢、
吳茱萸二錢、乾薑二錢
五付，每付用九碗煮三碗，早晚飯前各一碗。

解說：

由脈虛數無力且手冷額熱可知屬裏寒。初診用四逆湯，這次改用當歸四逆湯。但裏寒去掉時，如冰雪溶，小便量會增加。

腰部酸痛環腰而行是帶脈痛，藥用苓桂甘棗湯，針下足臨泣。

倪醫師病案紀錄	初診日期：2008/08/12		
姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**
Zhao Zhi-Hong	女	46歲，中等身材，偏瘦。	2008/08/25

來診原因：初診以憂鬱症為主訴來診，師診斷為真寒假熱，予四逆湯加減。二診時自言足較溫，仍有頭痛、噯氣。惡寒，時頭暈，帶脈痛。今日三診自言帶脈痛已去，月經過後有白帶。本次四診時主述頭痛仍有，偶爾心痛、左脇下刺痛、呼吸仍短氣，胃口仍不佳，不吃即餓，一吃又脹，劍突下一按即噯氣，近二日一醒來。

問診：

（1）頭痛：仍有，雙太陽穴痛，左側較重。
（2）胃口：不太好，時有噯氣，不吃即餓，一吃又脹。
（3）呼吸：短氣，吸入困難。
（4）腰痛：較上次改善，但仍有。
（5）心痛：偶爾有。
（6）脇痛：左肋下時刺痛。
（5）暈眩：較上次改善，但仍有。
（6）手足：手足涼，額溫。
（7）口渴：有一點渴，但不喜歡喝水。
（8）睡眠：近二天來醒後不易入睡，心煩。
（9）大便：一日一次，時有綠色糞，不消化食物多。
（10）情緒：易怒
（11）其他：心下一按就噯氣(心下痞)

脈診：脈緩無力

望診：無

舌診：淡黃紅，稍乾。

耳診：無。

診斷：裏陽虛仍有。

針灸處方：無。

中藥處方：
生附子二錢(布包)，乾薑二錢、炙甘草三錢
桂枝三錢、旋覆花二錢、代赭石三錢
川芎三錢、白芍六錢、柴胡三錢、鬱金五錢、黃芩三錢、枳實三錢
遠志三錢、龍骨三錢、熟地三錢、當歸二錢
10帖　9碗水煮成3碗　早晚飯前各喝一碗

解說：
脈緩重按無力，屬陽虛，如四肢水腫用生硫黃，無水腫用生附。
川芎治其頭痛，枳實治其心痛，旋覆花代赭石治其噯氣，師云左脇下刺痛與其噯氣有關。

倪醫師病案紀錄　初診日期：2008/8/14

姓名	**性別：**	**年齡及體型**	**來診日期：**
兌	男	41歲，中等，高	2008/8/14

來診原因:腸胃不適，心下痞，如有物在其中，一直不消化，心律不整，乾眼症，睡不好，雙手小指，無名指麻。

問診：
睡眠：時好時壞，近來最差。
大便：每天行，不成形。
小便淡黃。
手足冷。
胃口好。
口渴無。

脈診：緩有力（老師口述為洪數）。

望診：
舌診：黃濕，中間白。
眼診　：

特殊診斷：

耳診：

診斷：　調胃承氣湯症。

針灸處方：　雙手神門，後溪。

中藥處方：　調胃承氣湯4　決明子1
100 粒
8x3
三餐飯前

解說：
決明子→乾眼。

由舌苔可看出中焦濕熱。 胃氣會影響睡眠，服調胃承氣湯清出濁物，其他症狀應會消失。 針神門，後溪→手麻。
備註：

WORD 批量转 PDF 工具-未注册 注册码购买 QQ :3049816538(注册后本文字和以下内容消失)

点击我获得好运！！